

Mock NL Question Set

ข้อสอบจำลอง NL Part 1 (200 ข้อ) — ข้อสอบสร้างใหม่ 50 ข้อ พร้อม
คลังข้อสอบเก่า

ชุดข้อสอบ	MCQ 200 ข้อ · MEQ 0 ชุด · OSCE / SAQ 0 สถานี
คลังข้อสอบเก่า	0 ข้อ สกัดจาก MED28 – MED35
แยกตาม	Lecture ของ MED421/422 กลุ่มที่ 3 (C+D) รพ.ราชวิถี
รูปแบบข้อ	โจทย์ภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก · เฉลยและคำอธิบายภาษาไทย
หลักการออกข้อ	ทุกตัวเลือกมีเหตุผลรองรับ แต่ถูกเพียงข้อเดียว
ระบบนี้	ชุดจำลองศรว. ชั้นตอนที่ 1 · 200 ข้อ แยกตามระบบ 11 สาขา · เฉลยพร้อมคำอธิบายภาษาไทยรายข้อ

สารบัญ ส่วนที่ 0 หัวข้อที่ออกสอบบ่อย · ส่วนที่ 1 ข้อสอบใหม่ (โจทย์) · ส่วนที่ 2 เฉลยและคำอธิบาย · ส่วนที่ 3 คลัง
ข้อสอบเก่าแยกตาม lecture

คำเฉลยในโพยเก่าบางข้อไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน จุดที่ต่างถูกทำเครื่องหมายไว้ในคำอธิบาย เอกสารนี้ใช้ทบทวน
ประกอบตำราและแนวทางเวชปฏิบัติ ไม่ใช่เอกสารทางการของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 • ข้อสอบ

ทำโดยยังไม่ดูเฉลย — เฉลยอยู่ในส่วนที่ 2

Part 1 • MCQ — เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (200 ข้อ)

1. MOCK-001 • Lec M01 • Section 1 • Infectious disease

ข้อ 1 • The most appropriate management plan

A 24-year-old man presents with a 4-day history of high fever, severe retro-orbital headache, myalgias, and widespread body rash. On examination, he is febrile at 38.8°C, blood pressure is 110/70 mmHg, and pulse rate is 88/min. Laboratory investigation shows Hematocrit 44%, WBC 3,100/μL, and Platelet count 25,000/μL. There is no active mucosal or gastrointestinal bleeding. Which of the following is the most appropriate management plan?

- A. Administer prophylactic intravenous ceftriaxone
- B. Perform urgent bone marrow aspiration and biopsy
- C. Administer high-dose intravenous methylprednisolone
- D. Initiate intravenous fluid hydration and monitor serial hematocrit and clinical signs
- E. Transfuse 10 units of platelet concentrate immediately

2. MOCK-002 • Lec M01 • Section 1 • Infectious disease

ข้อ 2 • The drug of choice for this patient

A 45-year-old kidney transplant recipient presents with fever, productive cough, and right-sided pleuritic chest pain for 1 week. Chest radiograph demonstrates a right upper lobe cavitory infiltrate. Gram stain of the sputum shows weakly Gram-positive, branching filamentous rods. A modified acid-fast stain (Kinyoun) is positive. Which of the following is the drug of choice for this patient?

- A. Trimethoprim-sulfamethoxazole
- B. Penicillin G
- C. Amphoterecin B
- D. Vancomycin
- E. Metronidazole

3. MOCK-003 • Lec M01 • Section 1 • Infectious disease

ข้อ 3 • The most appropriate treatment

A 28-year-old forest ranger presents with a 5-day history of high fever, severe headache, conjunctival injection, and myalgias. Physical examination reveals a painless, 0.5-cm black necrotic ulcer with an erythematous halo on the right posterior neck, alongside tender cervical lymphadenopathy. Which of the following is the most appropriate treatment?

- A. Intravenous Acyclovir
- B. Oral Doxycycline
- C. Intravenous Penicillin G
- D. Oral Ciprofloxacin
- E. Oral Amoxicillin

ข้อ 4 · The most appropriate initial treatment

A 38-year-old man with untreated HIV infection (CD4 count 125 cells/ μ L) presents with a 2-week history of progressive exertional dyspnea, non-productive cough, and low-grade fever. Vital signs reveal blood pressure 110/70 mmHg, pulse 104/min, respiratory rate 26/min, and SpO₂ 86% on room air. Chest radiograph reveals bilateral diffuse symmetrical ground-glass opacities. Which of the following is the most appropriate initial treatment?

- A. Trimethoprim-sulfamethoxazole plus Prednisolone
- B. Ceftriaxone plus Azithromycin
- C. Oseltamivir plus Levofloxacin
- D. Ganciclovir plus Clindamycin
- E. Fluconazole plus Pyrimethamine

ข้อ 5 · The most likely diagnosis

A 20-year-old male presents with a 3-day history of high fever, maculopapular rash on the trunk and extremities, and severe, incapacitating polyarthralgia involving both knees, ankles, and wrists. Physical examination shows warmth and tenderness over the affected joints without purulent effusion. Complete blood count reveals WBC 3,500/ μ L and Platelet count 45,000/ μ L. Dengue NS1 antigen is negative. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Systemic lupus erythematosus
- B. Acute gouty arthritis
- C. Chikungunya fever
- D. Reactive arthritis
- E. Disseminated gonococcal infection

ข้อ 6 · The most appropriate management

A 7-year-old boy presents with a 2-day history of mild sore throat and low-grade fever. Physical examination shows mild pharyngeal injection without tonsillar exudates, palatal petechiae, or cervical lymphadenopathy. Lungs are clear on auscultation. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Intravenous Ceftriaxone single dose
- B. Azithromycin oral therapy for 5 days
- C. Amoxicillin oral therapy for 10 days
- D. Throat swab culture before starting oral Erythromycin
- E. Symptomatic relief with oral antipyretics and warm water gargle

ข้อ 7 · The recommended induction therapy

A 42-year-old man with advanced HIV infection presents with severe headache, fever, and neck stiffness. Physical examination reveals positive Kernig and Brudzinski signs. India ink preparation of the cerebrospinal fluid (CSF) shows encapsulated budding yeast cells. Which of the following is the recommended induction therapy?

- A. Intravenous Caspofungin plus Intrathecal Amphotericin B
- B. Liposomal Amphotericin B plus Flucytosine
- C. High-dose oral Fluconazole monotherapy
- D. Oral Itraconazole plus Cotrimoxazole
- E. Intravenous Voriconazole monotherapy

ข้อ 8 · The most appropriate management for the sexual partner

A 30-year-old individual is diagnosed with early latent syphilis. The patient reports having had a single sexual partner within the past 60 days. The partner is currently asymptomatic and nonreactive on RPR screening. Which of the following is the most appropriate management for the sexual partner?

- A. Reassure the partner that no treatment or follow-up is necessary
- B. Recheck RPR blood test in 3 months before deciding on treatment
- C. Perform darkfield microscopy on urethral/vaginal swab
- D. Administer Benzathine Penicillin G 2.4 million units IM as a single dose immediately
- E. Administer Doxycycline 100 mg orally twice daily for 28 days

ข้อ 9 · Which of the following radical cure drug regimens should be prescribed

A 32-year-old man presents with high fever, chills, and rigors following travel to an endemic area. Peripheral blood smear reveals ring-form trophozoites inside enlarged red blood cells with Schüffner's dots. The diagnosis of *Plasmodium vivax* malaria is established. Which of the following radical cure drug regimens should be prescribed?

- A. Atovaquone plus Proguanil
- B. Oral Quinine plus Doxycycline
- C. Chloroquine plus Primaquine
- D. Artesunate plus Mefloquine
- E. Intravenous Artesunate monotherapy

ข้อ 10 · The primary step in management

A 35-year-old flood-relief worker presents with 10 episodes of profuse, painless, watery diarrhea resembling 'rice water' accompanied by severe muscle cramps and vomiting. On examination, he is lethargic with sunken eyes and BP 80/50 mmHg. Which of the following is the primary step in management?

- A. Stool culture before initiating any therapy
- B. Immediate administration of oral loperamide
- C. Empirical intravenous vancomycin therapy
- D. Intravenous rehydration with isotonic crystalloid solution
- E. Oral administration of metronidazole

ข้อ 11 · The most appropriate intervention

A 26-year-old pregnant woman at 12 weeks of gestation undergoes routine antenatal screening. Midstream urine culture yields $> 10^5$ CFU/mL of Escherichia coli. She reports no urinary symptoms. Which of the following is the most appropriate intervention?

- A. Administer oral Ciprofloxacin for 3 days
- B. Repeat urine culture at 20 weeks of gestation
- C. Administer oral Amoxicillin or Nitrofurantoin for 5–7 days
- D. Administer oral Trimethoprim-sulfamethoxazole for 7 days
- E. Reassure the patient and perform no antimicrobial treatment

ข้อ 12 · The empiric antibiotic of choice

A 50-year-old man with alcoholic cirrhosis presents with diffuse abdominal pain, fever, and worsening ascites. Abdominal paracentesis reveals cloudy fluid with PMN count = 960/ μ L and protein 1.0 g/dL. Which of the following is the empiric antibiotic of choice?

- A. Oral Ciprofloxacin
- B. Intravenous Cefotaxime or Ceftriaxone
- C. Oral Amoxicillin-clavulanate
- D. Intravenous Vancomycin
- E. Intravenous Metronidazole

ข้อ 13 · The most urgent intervention

A 34-year-old woman with HIV presents with fever, temporal headache, confusion, and focal seizures. Brain MRI reveals asymmetric hyperintensity in the left temporal lobe. CSF analysis shows 120 WBCs/ μ L (lymphocytic) and RBC count 60/ μ L. Which of the following is the most urgent intervention?

- A. Intravenous Ceftriaxone plus Vancomycin
- B. Oral Fluconazole
- C. Intravenous Amphotericin B
- D. Intravenous Acyclovir
- E. Empiric anti-tuberculosis therapy (HRZE)

ข้อ 14 · Which of the following single-tablet regimens represents the preferred first-line ART

A 29-year-old treatment-naïve male diagnosed with HIV infection (CD4 count 210 cells/ μ L) is evaluated for antiretroviral therapy (ART) initiation. Renal function and baseline lab tests are normal. Which of the following single-tablet regimens represents the preferred first-line ART?

- A. Zidovudine / Lamivudine / Nevirapine
- B. Tenofovir disoproxil fumarate / Lamivudine / Dolutegravir (TLD)
- C. Stavudine / Lamivudine / Efavirenz
- D. Lopinavir / Ritonavir / Tenofovir
- E. Abacavir / Lamivudine / Efavirenz

ข้อ 15 · The most appropriate definitive antibiotic treatment

A 68-year-old male presents with acute fever, pleuritic chest pain, and rust-colored sputum. Chest radiograph demonstrates right lower lobe consolidation. Sputum Gram stain reveals Gram-positive lancet-shaped diplococci. Which of the following is the most appropriate definitive antibiotic treatment?

- A. Oral Vancomycin
- B. Intravenous Ceftazidime
- C. Oral Ciprofloxacin
- D. Intravenous Ceftriaxone
- E. Intravenous Metronidazole

ข้อ 16 · The most likely pathogen

A 19-year-old female presents with acute right knee pain, swelling, and fever. Physical examination reveals a warm, swollen right knee and two small necrotic pustules on an erythematous base on her forearm. Synovial fluid shows WBC 45,000/ μ L. Which of the following is the most likely pathogen?

- A. *Neisseria gonorrhoeae*
- B. *Staphylococcus aureus*
- C. *Borrelia burgdorferi*
- D. *Escherichia coli*
- E. *Streptococcus pneumoniae*

ข้อ 17 · Which of the following post-exposure prophylaxis regimens is indicated for the roommate

A 22-year-old college student is admitted with meningococcal meningitis confirmed by *Neisseria meningitidis* in CSF culture. His roommate is currently asymptomatic. Which of the following post-exposure prophylaxis regimens is indicated for the roommate?

- A. 10-day course of oral Amoxicillin
- B. 5-day course of oral Azithromycin
- C. Single dose of intramuscular Benzathine Penicillin G
- D. Single dose of oral Rifampin or single dose of oral Ciprofloxacin
- E. Observation without antimicrobial prophylaxis unless symptoms develop

ข้อ 18 · The most appropriate management

A 35-year-old man presents with chronic low-grade fever, night sweats, RLQ abdominal pain, and weight loss. Colonoscopy reveals ileocecal ulcerations, and biopsy shows granulomatous inflammation with central caseous necrosis. Which of the following is the most appropriate management?

- A. Surgical resection of the terminal ileum and cecum
- B. Empiric oral metronidazole and ciprofloxacin for 14 days
- C. Administer oral mesalamine and systemic corticosteroids
- D. Initiate standard 4-drug anti-tuberculosis therapy (HRZE)
- E. Initiate infliximab infusion therapy

ข้อ 19 · The best initial empiric antibiotic regimen

A 54-year-old woman presents with severe right flank pain, high fever (39.2°C), chills, and CVA tenderness. Urine dipstick shows leukocyte esterase (+), nitrites (+), and WBC casts. Which of the following is the best initial empiric antibiotic regimen?

- A. Oral Nitrofurantoin
- B. Intravenous Ceftriaxone
- C. Oral Erythromycin
- D. Oral Fosfomycin
- E. Intravenous Vancomycin

ข้อ 20 · The most likely organism

A 62-year-old hospitalized patient with a Foley catheter develops dysuria and suprapubic discomfort. Urine culture grows Gram-negative lactose-fermenting bacilli with a prominent mucoid capsule. Which of the following is the most likely organism?

- A. *Staphylococcus saprophyticus*
- B. *Enterococcus faecalis*
- C. *Pseudomonas aeruginosa*
- D. *Proteus mirabilis*
- E. *Klebsiella pneumoniae*

ข้อ 21 · The primary localized treatment of choice

A 65-year-old man presents with a slow-growing, pearly papule with central ulceration and telangiectasias on his right cheek. Skin biopsy confirms basal cell carcinoma. Which of the following is the primary localized treatment of choice?

- A. Systemic combination chemotherapy
- B. Wide local amputation
- C. Surgical excision with clear margins
- D. Topically applied 5-fluorouracil cream for 6 months
- E. Intralesional interferon-alpha injections

ข้อ 22 · The most appropriate diagnostic procedure

A 62-year-old male with a 40 pack-year smoking history presents with progressive dysphagia, initially to solid foods and now to liquids, over the past 3 months, accompanied by an 8-kg weight loss. Which of the following is the most appropriate diagnostic procedure?

- A. 24-hour ambulatory esophageal pH monitoring
- B. Computed tomography (CT) of the chest with IV contrast alone
- C. Barium swallow cine-radiography
- D. Esophageal high-resolution manometry
- E. Upper gastrointestinal endoscopy with tissue biopsy

ข้อ 23 · The primary definitive treatment strategy

A 58-year-old heavy smoker presents with a central lung mass. Serum lab shows Sodium 118 mEq/L, consistent with SIADH. Biopsy confirms small cell lung carcinoma (SCLC). Which of the following is the primary definitive treatment strategy?

- A. Systemic chemotherapy (Etoposide plus Cisplatin/Carboplatin)
- B. Inhaled bronchodilator therapy alone
- C. Monotherapy with oral tyrosine kinase inhibitors
- D. Surgical pneumonectomy
- E. Surgical wedge resection with hilar lymph node dissection

ข้อ 24 · Which of the following staging investigations is necessary prior to definitive management

A 60-year-old man presents with hematochezia and circumferential mass in the sigmoid colon. Biopsy yields adenocarcinoma. Which of the following staging investigations is necessary prior to definitive management?

- A. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
- B. Bone scan without abdominal cross-sectional imaging
- C. Whole-body positron emission tomography (PET) scan monotherapy
- D. Contrast-enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis
- E. Serum CEA measurement alone without imaging

ข้อ 25 · Which of the following systemic adjuvant therapies is indicated

A 50-year-old woman undergoes mastectomy for invasive ductal breast carcinoma (2.2 cm, margins negative, 0/12 axillary nodes, ER+, PR+, HER2-). Which of the following systemic adjuvant therapies is indicated?

- A. Adjuvant endocrine therapy (e.g., Tamoxifen or Aromatase Inhibitor)
- B. Adjuvant Trastuzumab monotherapy for 1 year
- C. Observation without systemic therapy
- D. Neoadjuvant systemic chemotherapy with Cisplatin
- E. Adjuvant bilateral oophorectomy alone

ข้อ 26 · The correct explanation

Following complete resection of stage II colon cancer, a patient asks about the primary objective of adjuvant chemotherapy. Which of the following is the correct explanation?

- A. To prevent benign colonic polyps from transforming into adenomas
- B. To eradicate microscopic residual metastatic disease and reduce the risk of disease recurrence
- C. To shrink the primary tumor mass prior to definitive surgical excision
- D. To convert unresectable liver metastases into resectable lesions
- E. To treat localized macroscopic surgical margin contamination

ข้อ 27 · Which of the following viral agents is recognized as the leading cause of hepatocellular c

An epidemiological study examines global incidence of primary liver malignancies. Which of the following viral agents is recognized as the leading cause of hepatocellular carcinoma (HCC) worldwide?

- A. Cytomegalovirus (CMV) infection
- B. Chronic Hepatitis B Virus (HBV) infection
- C. Human Papillomavirus (HPV) infection
- D. Hepatitis A Virus (HAV) infection
- E. Epstein-Barr Virus (EBV) infection

ข้อ 28 · The most likely diagnosis

A 55-year-old woman with treated right breast carcinoma 3 years ago presents with progressive headache and motor aphasia. Brain MRI reveals a single ring-enhancing lesion at the left frontal cortex with vasogenic edema. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Acute cerebral infarction
- B. Brain metastasis
- C. Primary glioblastoma multiforme
- D. Cerebral abscess
- E. Subdural hematoma

ข้อ 29 · Exposure to which substance is the primary etiologic factor

A 64-year-old former shipyard worker presents with progressive dyspnea, chest pain, and weight loss. Chest CT reveals nodular pleural thickening and pleural effusion. Biopsy confirms malignant mesothelioma. Exposure to which substance is the primary etiologic factor?

- A. Asbestos fibers
- B. Coal dust
- C. Silica dust
- D. Cotton dust
- E. Beryllium particles

ข้อ 30 · The most likely diagnosis

A 77-year-old woman presents with severe back pain, lethargy, Calcium 12.8 mg/dL, Creatinine 2.4 mg/dL, Hb 8.5 g/dL, total protein 10.2 g/dL (albumin 3.0 g/dL). Spine X-ray demonstrates punched-out lytic lesions. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Primary hyperparathyroidism
- B. Multiple myeloma
- C. Metastatic breast cancer
- D. Osteoarthritis
- E. Osteoporosis

ข้อ 31 · The primary mechanism of pleural effusion accumulation in this patient

A 68-year-old man presents with massive right pleural effusion. Cytological examination reveals malignant cells. Which of the following is the primary mechanism of pleural effusion accumulation in this patient?

- A. Decreased plasma oncotic pressure secondary to hypoalbuminemia
- B. Increased systemic venous pressure secondary to right heart failure
- C. Tumor invasion of pleural lymphatics leading to impaired lymphatic drainage
- D. Elevated intrahepatic sinusoidal pressure
- E. Decreased intrapleural pressure secondary to atelectasis

ข้อ 32 · The diagnostic test of choice

A 60-year-old man presents with early satiety, epigastric discomfort, weight loss, and a palpable firm left supraclavicular lymph node (Virchow's node). Which of the following is the diagnostic test of choice?

- A. Abdominal ultrasound
- B. Barium meal series
- C. Serum CA 19-9 measurement
- D. Stool occult blood testing
- E. Upper gastrointestinal endoscopy with mucosal biopsy

ข้อ 33 · Which of the following modalities is recommended by international clinical guidelines

A 68-year-old man with a 30 pack-year smoking history undergoes screening for lung cancer. Which of the following modalities is recommended by international clinical guidelines?

- A. Annual low-dose computed tomography (LDCT) of the chest
- B. Routine bronchoalveolar lavage
- C. Annual chest radiograph (PA view)
- D. Sputum cytology every 6 months
- E. Serum CEA and CYFRA 21-1 tumor markers

ข้อ 34 · The most likely diagnosis

A 45-year-old woman presents with persistent abdominal bloating and a solid, fixed adnexal mass on ultrasound with serum CA-125 elevated at 450 U/mL. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Polycystic ovary syndrome
- B. Benign dermoid cyst
- C. Epithelial ovarian carcinoma
- D. Endometrial adenocarcinoma
- E. Uterine leiomyoma

ข้อ 35 · Which malignancy is most strongly suggested

A 58-year-old male presents with painless jaundice, dark urine, pale stools, and a non-tender, distended gallbladder (Courvoisier sign). Which malignancy is most strongly suggested?

- A. Sigmoid colon carcinoma
- B. Renal cell carcinoma
- C. Pancreatic head adenocarcinoma
- D. Hepatocellular carcinoma
- E. Gastric adenocarcinoma

ข้อ 36 · The diagnosis

A 52-year-old man presents with gross painless hematuria, right flank pain, a palpable abdominal mass, and polycythemia (Hb 18.5 g/dL). CT shows hypervascular renal mass. Which of the following is the diagnosis?

- A. Renal angiomyolipoma
- B. Renal cell carcinoma
- C. Wilms tumor
- D. Transitional cell carcinoma of the bladder
- E. Acute pyelonephritis

ข้อ 37 · Which thyroid malignancy is indicated

A pathology report of fine-needle aspiration from a thyroid nodule describes psammoma bodies, ground-glass nuclei (Orphan Annie eyes), and nuclear grooves. Which thyroid malignancy is indicated?

- A. Follicular thyroid carcinoma
- B. Anaplastic thyroid carcinoma
- C. Medullary thyroid carcinoma
- D. Papillary thyroid carcinoma
- E. Primary thyroid lymphoma

ข้อ 38 · Which pharmacologic class reduces skeletal-related events

A 65-year-old man with metastatic castrate-resistant prostate cancer and bone metastases presents for palliative management. Which pharmacologic class reduces skeletal-related events?

- A. Bisphosphonates (e.g., Zoledronic acid) or Denosumab
- B. Systemic broad-spectrum antibiotics
- C. Calcitonin subcutaneous injections
- D. Loop diuretics
- E. High-dose oral corticosteroids alone

ข้อ 39 · Which laboratory serum profile is diagnostic of iron deficiency anemia

A 32-year-old woman presents with fatigue and heavy menstrual bleeding. CBC reveals Hb 8.2 g/dL, MCV 68 fL, MCH 21 pg (hypochromic microcytic). Which laboratory serum profile is diagnostic of iron deficiency anemia?

- A. Elevated Serum Ferritin, Elevated TIBC
- B. Decreased Serum Ferritin, Decreased TIBC
- C. Elevated Serum Ferritin, Decreased TIBC
- D. Normal Serum Ferritin, Normal TIBC
- E. Decreased Serum Ferritin, Elevated TIBC

ข้อ 40 · Which is the initial first-line treatment

A 28-year-old woman presents with petechiae and ecchymoses. CBC shows Plt 18,000/ μ L, Hb 13.5 g/dL, WBC 6,200/ μ L. PT and aPTT normal. Bone marrow shows increased megakaryocytes. Which is the initial first-line treatment?

- A. Intravenous Cyclophosphamide
- B. Intravenous Recombinant Factor VIIa
- C. Oral Prednisolone
- D. Platelet transfusion 10 units
- E. Immediate splenectomy

ข้อ 41 · Which mechanism accounts for these findings

A 60-year-old strict vegan woman presents with paresthesias, sensory ataxia, Hb 7.5 g/dL, MCV 112 fL, hypersegmented neutrophils. Which mechanism accounts for these findings?

- A. Impaired DNA synthesis during erythropoiesis secondary to Vitamin B12 deficiency
- B. Red blood cell membrane instability secondary to Ankyrin mutation
- C. Glucosylceramides accumulation secondary to enzyme deficiency
- D. Accelerated intravascular hemolysis secondary to autoantibodies
- E. Impaired heme synthesis secondary to Iron deficiency

ข้อ 42 · Which testing set confirms von Willebrand Disease (vWD)

A 25-year-old woman with bleeding history presents with epistaxis and menorrhagia. Coagulation: normal PT, prolonged aPTT, bleeding time prolonged. Which testing set confirms von Willebrand Disease (vWD)?

- A. Factor IX activity assay and Thrombin time
- B. Platelet aggregation test with ADP alone
- C. Bone marrow aspirate and CD34 cell count
- D. von Willebrand Factor (vWF) antigen, Ristocetin cofactor activity, and Factor VIII assay
- E. Fibrinogen degradation products and D-dimer assay

ข้อ 43 · Which characterizes this defect

A 14-year-old boy presents with right knee hemarthrosis. Maternal uncle has bleeding disorder. Coagulation: normal PT, prolonged aPTT (65s), corrects with 1:1 mixing study. Which characterizes this defect?

- A. Vascular wall fragility
- B. Defect in primary hemostasis (platelet adhesion failure)
- C. Antithrombin III deficiency
- D. Fibrinolytic pathway hyperactivation
- E. Defect in secondary hemostasis (coagulation cascade factor deficiency)

44. MOCK-044 · Lec M03 · Section 3 · Hematology

ข้อ 44 · Which is the most likely diagnosis

A 52-year-old man presents with massive splenomegaly, WBC 145,000/ μ L with full spectrum of granulocyte maturation, t(9;22)(q34;q11) Philadelphia chromosome. Which is the most likely diagnosis?

- A. Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
- B. Leukemoid reaction
- C. Primary Myelofibrosis
- D. Acute Myeloid Leukemia (AML)
- E. Chronic Myeloid Leukemia (CML)

45. MOCK-045 · Lec M03 · Section 3 · Hematology

ข้อ 45 · Which is the diagnosis

A 58-year-old woman has persistent platelet count 1,250,000/ μ L, megakaryocytic hyperplasia, and positive JAK2 V617F mutation without dysplasia. Which is the diagnosis?

- A. Reactive thrombocytosis
- B. Myelodysplastic Syndrome
- C. Chronic Myelomonocytic Leukemia
- D. Essential Thrombocythemia
- E. Acute Megakaryoblastic Leukemia

46. MOCK-046 · Lec M03 · Section 3 · Hematology

ข้อ 46 · What is the immediate step

30 mins into PRBC transfusion, patient develops fever 39.5°C, flank pain, hypotension (80/50), dark red urine, Coombs test positive. What is the immediate step?

- A. Administer intramuscular Adrenaline and continue transfusion
- B. Transfuse 2 units of Fresh Frozen Plasma through the same line
- C. Administer intravenous Furosemide and decrease IV fluids
- D. Slow down the transfusion rate and administer oral Paracetamol
- E. Stop the blood transfusion immediately and initiate aggressive intravenous normal saline hydration

47. MOCK-047 · Lec M03 · Section 3 · Hematology

ข้อ 47 · Mechanism of this reaction

During transfusion, patient develops fever rise from 36.8 to 38.2°C with mild chills. BP, HR, SpO₂, urine color normal. Coombs test negative. Mechanism of this reaction?

- A. Recipient antibodies directed against donor white blood cells and cytokines released during storage
- B. Transfusion of bacterial-contaminated blood products
- C. Fluid volume overload causing hydrostatic pulmonary capillary congestion
- D. IgA deficiency in the recipient with anti-IgA antibodies reacting against donor plasma
- E. ABO incompatibility causing complement-mediated intravascular hemolysis

ข้อ 48 · Which is the diagnosis

Patient receiving rapid 4 units PRBC transfusion develops severe dyspnea, hypertension (170/100), JVD, bilateral crackles, cardiomegaly on X-ray. Which is the diagnosis?

- A. Sepsis secondary to bacterial contamination
- B. Transfusion-Related Acute Lung Injury (TRALI)
- C. Transfusion-Associated Circulatory Overload (TACO)
- D. Anaphylactic transfusion reaction
- E. Acute Hemolytic Transfusion Reaction

ข้อ 49 · What explains this coagulopathy

Trauma patient receives 14 units PRBCs without FFP or platelets, develops oozing from venipunctures, prolonged PT/aPTT, Plt 35k. What explains this coagulopathy?

- A. Vitamin K deficiency
- B. Pre-existing Factor VIII inhibitor
- C. Dilutional coagulopathy and thrombocytopenia
- D. Primary fibrinolysis activation
- E. Heparin-induced thrombocytopenia

ข้อ 50 · Which enzyme deficiency

Male presents with jaundice and dark urine 2 days after starting Primaquine for *P. vivax*. Blood smear demonstrates bite cells and Heinz bodies. Which enzyme deficiency?

- A. Pyruvate Kinase deficiency
- B. UDP-glucuronosyltransferase deficiency
- C. Methemoglobin reductase deficiency
- D. Glucocerebrosidase deficiency
- E. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) deficiency

ข้อ 51 · Primary diagnosis

A 48-year-old man presents with severe generalized pruritus after hot bath, Hb 19.5 g/dL, Hct 58%, WBC 14k, Plt 550k, suppressed serum EPO, splenomegaly. Primary diagnosis?

- A. Erythropoietin-secreting renal cell carcinoma
- B. Polycythemia Vera
- C. Secondary erythrocytosis due to chronic hypoxia
- D. Essential Thrombocythemia
- E. Relative polycythemia (dehydration)

ข้อ 52 · Long-term management

Woman with recurrent DVT and 3 first-trimester pregnancy losses, prolonged aPTT not corrected by mixing study, lupus anticoagulant positive twice 12 wks apart. Long-term management?

- A. Prophylactic platelet transfusions
- B. Short-term oral corticosteroid therapy
- C. Long-term oral anticoagulation therapy
- D. Low-dose aspirin monotherapy
- E. Long-term intravenous immunoglobulin infusions

ข้อ 53 · Which agent rapidly corrects uremic bleeding prior to procedure

ESRD patient on HD has easy bruising and prolonged bleeding time with normal Plt count and PT/aPTT. Which agent rapidly corrects uremic bleeding prior to procedure?

- A. Recombinant Factor VIII concentrate
- B. Desmopressin (dDAVP) or Cryoprecipitate
- C. Tranexamic acid monotherapy
- D. Fresh Frozen Plasma transfusion
- E. Vitamin K1 intravenous infusion

ข้อ 54 · Main mechanism responsible

Woman 5 yrs post-gastrectomy presents with macrocytic anemia (MCV 115 fL, Vit B12 90 pg/mL low) and atrophic glossitis. Main mechanism responsible?

- A. Chronic occult gastrointestinal blood loss causing iron depletion
- B. Loss of parietal cell mass resulting in Intrinsic Factor deficiency and impaired ileal B12 absorption
- C. Malabsorption of pyridoxine due to gastrectomy
- D. Bacterial overgrowth in the blind loop consuming dietary folate
- E. Autoimmune destruction of terminal ileal enterocytes

ข้อ 55 · Diagnosis

16yo boy of Mediterranean descent, asymptomatic mild anemia (Hb 10.8), high RBC count 6.2, low MCV 62 fL, normal RDW 12.5%, HbA2 elevated at 4.8%. Diagnosis?

- A. Anemia of chronic disease
- B. Sideroblastic anemia
- C. Iron deficiency anemia
- D. Beta-thalassemia trait (minor)
- E. Hemoglobin H disease

56. MOCK-056 · Lec M03 · Section 3 · Hematology

ข้อ 56 • Diagnosis

35yo woman presents with fatigue, bruising, fever. CBC: Hb 6.2, WBC 1,200 (ANC 200), Plt 12,000, Reticulocyte 0.1%. Bone marrow shows >90% fat space replacement. Diagnosis?

- A. Megaloblastic Anemia
- B. Myelodysplastic Syndrome
- C. Acute Lymphoblastic Leukemia
- D. Primary Myelofibrosis
- E. Aplastic Anemia

57. MOCK-057 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 57 • Diagnosis

38yo woman presents with proximal muscle weakness, violaceous rash on upper eyelids (heliotrope rash), flat erythematous papules over IP joints (Gottron papules), CK 4500 U/L. Diagnosis?

- A. Mixed Connective Tissue Disease
- B. Dermatomyositis
- C. Systemic Lupus Erythematosus
- D. Polymyositis
- E. Systemic Sclerosis

58. MOCK-058 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 58 • Diagnosis

28yo woman taking OCPs presents with painful red subcutaneous nodules on anterior lower legs. Biopsy reveals septal panniculitis without vasculitis. Diagnosis?

- A. Cellulitis
- B. Pyoderma gangrenosum
- C. Erythema nodosum
- D. Erythema induratum
- E. Superficial thrombophlebitis

59. MOCK-059 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 59 • Diagnosis

Nurse develops dry scaly erythematous patches and fissures on hands after frequent alcohol hand rub use. No lesions elsewhere. Diagnosis?

- A. Plaque psoriasis
- B. Irritant contact dermatitis
- C. Allergic contact dermatitis
- D. Tinea manuum
- E. Dyshidrotic eczema

ข้อ 60 • Diagnosis

30yo man presents with intensely pruritic, deep-seated 'tapioca-like' vesicles along lateral fingers and palms recurrently during warm weather/stress. Diagnosis?

- A. Bullous impetigo
- B. Scabies
- C. Contact dermatitis
- D. Herpetic whitlow
- E. Dyshidrosis (Pompholyx)

ข้อ 61 • Primary pathogen

60yo diabetic male presents with bright red, shiny, swollen, sharply demarcated plaque on cheek with earlobe involvement (Milium's ear sign), high fever. Primary pathogen?

- A. Pseudomonas aeruginosa
- B. Mycobacterium marinum
- C. Candida albicans
- D. Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus)
- E. Staphylococcus aureus

ข้อ 62 • Most appropriate antiviral therapy

55yo man presents with painful grouped vesicles on erythematous base along right T6 dermatome. Most appropriate antiviral therapy?

- A. Topical Ketoconazole 2% cream for 14 days
- B. Oral Acyclovir 800 mg 5 times daily (or Valacyclovir 1,000 mg tid) for 7 days
- C. Oral Oseltamivir 75 mg twice daily for 5 days
- D. Topical Hydrocortisone 1% cream monotherapy
- E. Intravenous Ganciclovir for 21 days

ข้อ 63 • Recommended first-line topical treatment

42yo male presents with pruritic, purple, polygonal, flat-topped papules on flexor wrists with Wickham's striae. Recommended first-line topical treatment?

- A. Topical Acyclovir ointment
- B. Topical Permethrin 5% lotion
- C. Topical Antifungal (e.g., Clotrimazole cream)
- D. Topical high-potency corticosteroid (e.g., Clobetasol propionate)
- E. Topical Coal tar preparation

ข้อ 64 · Most effective oral treatment regimen

50yo farmer presents with thickened dystrophic yellowish toenail, subungual hyperkeratosis. KOH shows septate hyphae. Most effective oral treatment regimen?

- A. Oral Terbinafine 250 mg daily for 12 weeks
- B. Oral Griseofulvin 500 mg daily for 2 weeks
- C. Topical Hydrocortisone cream daily for 8 weeks
- D. Oral Metronidazole 400 mg tid for 7 days
- E. Oral Nystatin 500,000 units tid for 4 weeks

ข้อ 65 · Responsible toxin

4yo boy presents with painless flaccid bullae on face that rupture easily leaving honey-colored crusts. Responsible toxin?

- A. Exfoliative toxin A produced by *Staphylococcus aureus*
- B. Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1)
- C. Shiga toxin produced by *E. coli*
- D. Alpha toxin produced by *Clostridium perfringens*
- E. Erythrogenic toxin produced by *Streptococcus pyogenes*

ข้อ 66 · Diagnosis

Woman develops targetoid macules and flaccid bullae involving 25% BSA with oral/ocular mucosal erosions 10 days post-TMP-SMX, Nikolsky sign positive. Diagnosis?

- A. Erythema multiforme minor
- B. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP)
- C. Stevens-Johnson Syndrome / Toxic Epidermal Necrolysis (SJS/TEN overlap)
- D. Bullous pemphigoid
- E. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)

ข้อ 67 · Underlying immunopathogenesis

Man presents with erythematous plaques covered with thick silvery scales on extensor knees/elbows, Auspitz sign positive. Underlying immunopathogenesis?

- A. T-cell mediated autoimmune epidermal hyperplasia and keratinocyte hyperproliferation
- B. Deposition of IgA immune complexes in the dermal papillae
- C. Type I IgE-mediated mast cell degranulation
- D. Direct bacterial infection of the stratum corneum
- E. Autoantibodies against desmoglein-1 and desmoglein-3

ข้อ 68 • Diagnosis

75yo woman presents with tense non-rupturing bullae on lower abdomen/thighs, mucosa spared. DIF shows linear IgG and C3 deposition along basement membrane. Diagnosis?

- A. Pemphigoid vulgaris
- B. Epidermolysis bullosa acquisita
- C. Bullous pemphigoid
- D. Porphyria cutanea tarda
- E. Dermatitis herpetiformis

ข้อ 69 • Pathogenic autoantibodies

Man presents with painful flaccid blisters on trunk and severe oral erosions, positive Nikolsky sign, DIF shows intercellular net-like IgG. Pathogenic autoantibodies?

- A. Anti-type VII collagen antibodies
- B. Anti-desmoglein-3 (and Anti-desmoglein-1) antibodies
- C. Anti-epidermal transglutaminase IgA antibodies
- D. Anti-topoisomerase I antibodies
- E. Anti-hemidesmosomal (BP180 / BP230) antibodies

ข้อ 70 • Treatment of choice

Student presents with intense nocturnal itching, papules and burrows in finger webs, flexor wrists. Roommate affected. Treatment of choice?

- A. Topical Permethrin 5% cream applied overnight from neck down
- B. Oral Griseofulvin 500 mg daily for 4 weeks
- C. Subcutaneous Methotrexate injection
- D. Topical Clobetasol propionate 0.05% cream for 10 days
- E. Topical Ketoconazole 2% shampoo

ข้อ 71 • Acnes

Adolescent with facial comedones, inflammatory papules, and pustules. First-line pharmacotherapy targeting follicular hyperkeratinization and C. acnes?

- A. Topical Metronidazole 0.75% gel
- B. Topical Nystatin ointment
- C. Topical Hydrocortisone 1% cream
- D. Topical Retinoid (e.g., Tretinoin or Adapalene) plus Benzoyl Peroxide
- E. Topical Permethrin 5% lotion

72. MOCK-072 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 72 · Causative organism

Male presents with oval hypopigmented scaly macules on upper chest/back, Wood lamp yellow-gold fluorescence, KOH shows 'spaghetti and meatballs'. Causative organism?

- A. Malassezia furfur (globosa)
- B. Epidermophyton floccosum
- C. Microsporum canis
- D. Candida tropicalis
- E. Trichophyton rubrum

73. MOCK-073 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 73 · Diagnosis

Woman presents with well-circumscribed completely hairless oval patches on scalp without scaling or scarring, exclamation mark hairs at margin. Diagnosis?

- A. Telogen effluvium
- B. Androgenetic alopecia
- C. Alopecia areata
- D. Tinea capitis
- E. Trichotillomania

74. MOCK-074 · Lec M04 · Section 4 · Dermatology

ข้อ 74 · Most effective topical therapy

Man presents with greasy yellowish scales on scalp, eyebrows, nasolabial folds worsening in winter. Most effective topical therapy?

- A. Oral Terbinafine for 12 weeks
- B. Topical Antifungal (e.g., Ketoconazole 2% shampoo/cream)
- C. High-potency systemic corticosteroid therapy
- D. Topical Mupirocin 2% ointment
- E. Topical Permethrin 5% cream

75. MOCK-075 · Lec M05 · Section 5 · Rheumatology

ข้อ 75 · Disease-modifying agent initiated in all SLE patients

26yo woman presents with fever, malar rash, symmetric wrist arthralgias, leukopenia, 3+ proteinuria, ANA 1:640. Disease-modifying agent initiated in all SLE patients?

- A. High-dose Intravenous Cyclophosphamide
- B. Infliximab
- C. Tofacitinib
- D. Hydroxychloroquine
- E. Oral Methotrexate monotherapy

ข้อ 76 · Diagnosis

34yo female has overlap features of SLE, systemic sclerosis, and polymyositis. Lab shows markedly elevated anti-U1 RNP antibodies. Diagnosis?

- A. Diffuse Systemic Sclerosis
- B. Rheumatoid Arthritis
- C. Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)
- D. Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
- E. Dermatomyositis

ข้อ 77 · Diagnosis

68yo woman presents with chronic progressive bilateral knee pain worse with weight-bearing, morning stiffness 15 mins, bony enlargement, crepitus, X-ray osteophytes and joint space narrowing. Diagnosis?

- A. Septic arthritis
- B. Pseudogout
- C. Rheumatoid arthritis
- D. Osteoarthritis
- E. Gouty arthritis

ข้อ 78 · Acute management of choice

52yo male presents with sudden excruciating pain/swelling in right 1st MTP joint. Synovial fluid shows needle-shaped strongly negatively birefringent crystals. Acute management of choice?

- A. Oral Febuxostat plus Pegloticase
- B. Intra-articular amphotericin B injection
- C. Intravenous Ceftriaxone
- D. Oral NSAIDs (e.g., Indomethacin) or Colchicine
- E. Allopurinol initiation immediately at maximum dose

ข้อ 79 · Responsible crystal type

70yo woman with acute left knee arthritis. Arthrocentesis shows rhomboid-shaped weakly positively birefringent crystals. Radiographs show chondrocalcinosis. Responsible crystal type?

- A. Oxalate crystals
- B. Basic calcium phosphate
- C. Monosodium urate
- D. Cholesterol crystals
- E. Calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD)

ข้อ 80 · Diagnosis

12yo boy presents with migratory polyarthritis and new apical holosystolic murmur 3 weeks after untreated sore throat. ASO titer elevated (800 IU/mL). Diagnosis?

- A. Reactive Arthritis
- B. Juvenile Idiopathic Arthritis
- C. Post-streptococcal Glomerulonephritis
- D. Disseminated Gonococcal Infection
- E. Acute Rheumatic Fever

ข้อ 81 · First-line pharmacotherapy

28yo male with inflammatory back pain, morning stiffness 2 hours improving with activity, restricted lumbar flexion, bilateral sacroiliitis on X-ray, HLA-B27 positive. First-line pharmacotherapy?

- A. Allopurinol
- B. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
- C. Methotrexate
- D. Systemic corticosteroids
- E. Hydroxychloroquine

ข้อ 82 · Anchor first-line DMARD

45yo female with symmetric PIP/MCP/wrist joint arthritis > 6 wks, morning stiffness 90 mins, subcutaneous nodules, anti-CCP positive. Anchor first-line DMARD?

- A. Rituximab
- B. Methotrexate
- C. Azathioprine
- D. Sulfasalazine monotherapy
- E. Cyclophosphamide

ข้อ 83 · Specific clinical entity

48yo woman with Raynaud phenomenon, sclerodactyly, esophageal dysmotility, telangiectasias, positive anti-centromere antibodies. Specific clinical entity?

- A. Systemic Lupus Erythematosus
- B. Diffuse Systemic Sclerosis
- C. Granulomatosis with Polyangiitis
- D. Limited Systemic Sclerosis (CREST syndrome)
- E. Eosinophilic Fasciitis

84. MOCK-084 · Lec M05 · Section 5 · Rheumatology

ข้อ 84 • Diagnosis

50yo woman presents with severe dry eyes, dry mouth, Schirmer test < 5mm, positive Anti- SSA (Ro) and Anti-SSB (La). Diagnosis?

- A. Sarcoidosis
- B. Systemic Sclerosis
- C. Sjögren Syndrome
- D. IgG4-related disease
- E. Amyloidosis

85. MOCK-085 · Lec M05 · Section 5 · Rheumatology

ข้อ 85 • Diagnosis

42yo man with recurrent bloody nasal discharge, saddle nose, hemoptysis, elevated Cr, RBC casts, c-ANCA / Anti-PR3 positive. Diagnosis?

- A. Goodpasture Syndrome
- B. Microscopic Polyangiitis
- C. Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg-Strauss)
- D. Henoch-Schönlein Purpura
- E. Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener's)

86. MOCK-086 · Lec M05 · Section 5 · Rheumatology

ข้อ 86 • Diagnosis

25yo male presents with left ankle/right knee arthritis, enthesitis, conjunctivitis, dysuria 2 weeks post Campylobacter gastroenteritis, HLA-B27 positive. Diagnosis?

- A. Gouty arthritis
- B. Rheumatoid arthritis
- C. Reactive arthritis
- D. Septic arthritis
- E. Ankylosing spondylitis

87. MOCK-087 · Lec M05 · Section 5 · Rheumatology

ข้อ 87 • Diagnosis

68yo woman presents with severe aching/stiffness in shoulder and pelvic girdles, no muscle weakness, ESR 85, dramatic response to low-dose Prednisolone (15 mg/day) in 48h. Diagnosis?

- A. Polymyalgia Rheumatica
- B. Polymyositis
- C. Fibromyalgia
- D. Osteoarthritis
- E. Rheumatoid Arthritis

ข้อ 88 · Most urgent step to prevent permanent vision loss

72yo woman presents with severe temporal headache, scalp tenderness, jaw claudication, ESR 105 mm/hr. Most urgent step to prevent permanent vision loss?

- A. Wait for temporal artery biopsy results before starting corticosteroids
- B. Initiate high-dose oral Methotrexate therapy
- C. Order a urgent non-contrast CT brain scan
- D. Administer intravenous recombinant tissue plasminogen activator
- E. Initiate high-dose systemic corticosteroid therapy immediately

ข้อ 89 · Diagnosis

35yo woman presents with chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue, multiple specific tender points without joint swelling. ESR, CRP, ANA, CK completely normal. Diagnosis?

- A. Rheumatoid Arthritis
- B. Polymyositis
- C. Systemic Lupus Erythematosus
- D. Fibromyalgia
- E. Hypothyroidism

ข้อ 90 · Immediate plan

32yo male with acute monoarthritis of right knee, turbid synovial fluid WBC 85,000/ μ L (95% neutrophils), Gram-positive cocci in clusters. Immediate plan?

- A. Intra-articular corticosteroid injection
- B. Oral Allopurinol and NSAIDs
- C. Oral Methotrexate and Paracetamol
- D. Joint drainage (arthroscopic/needle lavage) and intravenous empirical antibiotics (e.g., Vancomycin)
- E. Outpatient oral ciprofloxacin therapy

ข้อ 91 · Diagnosis

28yo male presents with recurrent painful oral aphthous ulcers, genital ulcers, anterior uveitis, positive pathergy test. Diagnosis?

- A. Inflammatory Bowel Disease
- B. Reactive Arthritis
- C. Behçet Disease
- D. Herpes Simplex Virus infection
- E. Systemic Lupus Erythematosus

ข้อ 92 · Prior to initiating urate-lowering therapy, which co-prescription is necessary to prevent

60yo male with chronic gout starting Allopurinol. Prior to initiating urate-lowering therapy, which co-prescription is necessary to prevent acute gout flare?

- A. Low-dose oral Colchicine or NSAID prophylaxis
- B. Probenecid co-administration
- C. Oral Febuxostat co-administration
- D. High-dose oral Prednisolone for 6 months
- E. Intravenous rasburicase infusion

ข้อ 93 · Most appropriate acute intervention

65yo man presents with sudden right hemiparesis 1h ago, BP 160/90, CT brain shows no hemorrhage/infarct, no contraindications. Most appropriate acute intervention?

- A. Oral Warfarin therapy
- B. Intravenous unfractionated heparin bolus
- C. Oral Aspirin 300 mg loading dose monotherapy
- D. Intravenous recombinant tissue plasminogen activator (rtPA / Alteplase)
- E. Immediate surgical decompressive craniectomy

ข้อ 94 · Anatomical lesion located

60yo man with stroke can comprehend language fully but speech is non-fluent, slow, effortful, restricted to single words. Anatomical lesion located?

- A. Right parietal lobe
- B. Left superior temporal gyrus (Wernicke's area)
- C. Arcuate fasciculus
- D. Left inferior frontal gyrus (Broca's area)
- E. Nodule of the cerebellum

ข้อ 95 · Which structure is directly compressed against tentorium cerebelli

TBI patient develops uncal herniation, ipsilateral fixed dilated pupil and ptosis. Which structure is directly compressed against tentorium cerebelli?

- A. Oculomotor nerve (CN III) carrying parasympathetic fibers
- B. Optic nerve (CN II)
- C. Trochlear nerve (CN IV)
- D. Edinger-Westphal nucleus inside the pons
- E. Abducens nerve (CN VI)

96. MOCK-096 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 96 · Neuroanatomical localization best explaining altered sensorium

68yo diabetic male brought confused, bilateral flapping tremor (asterixis) elicited. Neuroanatomical localization best explaining altered sensorium?

- A. Focal cerebellar hemorrhage
- B. Unilateral left cerebral cortex lesion
- C. Unilateral right middle cerebral artery infarction
- D. Isolated brainstem lesion
- E. Diffuse cerebral cortical / metabolic encephalopathy

97. MOCK-097 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 97 · Drug of choice

Chronic alcohol dependence patient on day 3 becomes agitated, tremulous, diaphoresis, visual hallucinations, BP 170/100, HR 125. Drug of choice?

- A. Intravenous Phenytoin
- B. Oral Chlorpromazine
- C. Oral Haloperidol monotherapy
- D. Intravenous or oral Lorazepam (or Diazepam)
- E. Intravenous Metoprolol

98. MOCK-098 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 98 · Diagnosis

35yo woman presents with bilateral dull band-like pressing headache 15 days/month, no nausea, photophobia, or aggravation by activity. Diagnosis?

- A. Trigeminal neuralgia
- B. Idiopathic intracranial hypertension
- C. Migraine without aura
- D. Tension-type headache
- E. Cluster headache

99. MOCK-099 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 99 · Single most critical historical element required to determine eligibility for IV thromboly

Stroke code activated for 70yo woman. Single most critical historical element required to determine eligibility for IV thrombolysis?

- A. Family history of cerebrovascular disease
- B. History of recent dietary intake
- C. History of tobacco smoking pack-years
- D. Exact time of symptom onset (or time last known well)
- E. History of baseline lipid profile levels

100. MOCK-100 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 100 • Diagnosis

30yo woman presents with sudden onset of 'worst headache of life', nausea, neck stiffness. CT brain demonstrates hyperdensity in basal cisterns. Diagnosis?

- A. Migraine with aura
- B. Cerebral venous sinus thrombosis
- C. Temporal arteritis
- D. Acute ischemic stroke
- E. Subarachnoid hemorrhage

101. MOCK-101 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 101 • Diagnosis

28yo male presents with progressive symmetric lower-to-upper extremity weakness, absent DTRs (0/4), normal sensory, CSF protein 180 with WBC 3 cells/ μ L. Diagnosis?

- A. Acute transverse myelitis
- B. Guillain-Barré Syndrome (Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy)
- C. Amyotrophic lateral sclerosis
- D. Periodic hypokalemic paralysis
- E. Myasthenia gravis

102. MOCK-102 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 102 • Diagnosis

25yo woman presents with fluctuating ptosis, diplopia, fatigable weakness worsening at end of day, decremental nerve stimulation, positive anti-AChR antibodies. Diagnosis?

- A. Polymyositis
- B. Botulism
- C. Myasthenia Gravis
- D. Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome
- E. Guillain-Barré Syndrome

103. MOCK-103 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 103 • Diagnosis

32yo woman with history of optic neuritis now presents with lower extremity weakness, Lhermitte sign, CSF oligoclonal bands, brain MRI Dawson fingers. Diagnosis?

- A. Central pontine myelinolysis
- B. Multiple Sclerosis
- C. Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)
- D. Neuromyelitis Optica (NMO)
- E. Subacute combined degeneration

104. MOCK-104 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 104 · Which neurotransmitter deficiency in substantia nigra pars compacta

65yo man presents with resting pill-rolling tremor, bradykinesia, cogwheel rigidity, festinating gait. Which neurotransmitter deficiency in substantia nigra pars compacta?

- A. Dopamine
- B. Glutamate
- C. Gamma-aminobutyric acid (GABA)
- D. Serotonin
- E. Acetylcholine

105. MOCK-105 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 105 · Action required prior to performing lumbar puncture

40yo patient presents with fever, severe neck stiffness, confusion, papilledema. Action required prior to performing lumbar puncture?

- A. Wait 24 hours while observing neurological signs
- B. Perform a cerebral angiography
- C. Administer high-dose intravenous mannitol
- D. Obtain an immediate skull radiograph
- E. Perform a non-contrast CT scan of the brain to rule out mass effect and herniation risk

106. MOCK-106 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 106 · Diagnosis

58yo hypertensive woman presents with headache, vomiting, right hemiplegia. CT reveals 4-cm hyperdense hematoma in left basal ganglia. Diagnosis?

- A. Subarachnoid hemorrhage
- B. Intracerebral hemorrhage
- C. Acute ischemic cerebral infarction
- D. Epidural hematoma
- E. Cerebral venous thrombosis

107. MOCK-107 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 107 · Effective acute abortive treatment

35yo man presents with recurrent attacks of excruciating unilateral periorbital stabbing pain lasting 45 mins, ipsilateral lacrimation and rhinorrhea. Effective acute abortive treatment?

- A. Oral Indomethacin
- B. 100% High-flow oxygen inhalation via non-rebreather mask
- C. Oral Diazepam
- D. Oral Paracetamol 1,000 mg
- E. Intravenous Phenytoin

108. MOCK-108 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 108 · Pharmacologic agent indicated for acute abortive therapy

28yo woman presents with unilateral pulsating headaches with nausea, photophobia, visual scintillating scotomas aura. Pharmacologic agent indicated for acute abortive therapy?

- A. Oral Topiramate
- B. Intravenous Morphine
- C. Oral or subcutaneous Triptan (e.g., Sumatriptan)
- D. Oral Amitriptyline
- E. Oral Propranolol

109. MOCK-109 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 109 · Diagnosis

75yo male presents with classic triad of gait ataxia ('wobbly'), urinary incontinence ('wet'), and cognitive decline ('wacky'). MRI shows ventriculomegaly. Lumbar tap test improves gait. Diagnosis?

- A. Parkinson's disease dementia
- B. Progressive Supranuclear Palsy
- C. Normal Pressure Hydrocephalus (NPH)
- D. Vascular dementia
- E. Alzheimer's disease

110. MOCK-110 · Lec M06 · Section 6 · Neurology

ข้อ 110 · First-line intravenous medication

20yo male brought active in generalized tonic-clonic seizure persisting for 12 minutes without recovery of consciousness. First-line intravenous medication?

- A. Intravenous Propofol infusion
- B. Oral Valproic acid
- C. Intravenous General Anesthesia
- D. Intravenous Lorazepam (or Diazepam)
- E. Intravenous Phenobarbital

111. MOCK-111 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 111 · Diagnosis

35yo woman presents with dyspnea. Auscultation reveals loud S1, opening snap following S2, low-pitched mid-diastolic rumbling murmur at apex in left lateral position. Diagnosis?

- A. Mitral stenosis
- B. Mitral regurgitation
- C. Aortic regurgitation
- D. Aortic stenosis
- E. Tricuspid regurgitation

112. MOCK-112 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 112 · Hemodynamic mechanism causing shock

48yo male in MVA develops BP 75/40, JVD, muffled heart sounds (Beck's triad), pulsus paradoxus 18 mmHg. Hemodynamic mechanism causing shock?

- A. Cardiogenic shock due to acute left ventricular myocardial infarction
- B. Obstructive shock due to pericardial tamponade restricting ventricular diastolic filling
- C. Hypovolemic shock due to acute intravascular volume loss
- D. Distributive shock due to systemic vasodilation
- E. Neurogenic shock due to cervical spinal cord transection

113. MOCK-113 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 113 · AV block type

ECG on asymptomatic male shows progressive lengthening of PR interval until P wave fails to conduct, resulting in dropped QRS complex. Pattern repeats. AV block type?

- A. First-degree AV block
- B. Second-degree AV block, Mobitz Type II
- C. Second-degree AV block, Mobitz Type I (Wenckebach)
- D. Third-degree (Complete) AV block
- E. Sinoatrial exit block

114. MOCK-114 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 114 · Most appropriate long-term antithrombotic management

72yo man with non-valvular AF, T2DM, prior stroke (CHA2DS2-VASc = 5). Most appropriate long-term antithrombotic management?

- A. No antithrombotic therapy required
- B. Oral Anticoagulation (e.g., DOAC such as Apixaban or Warfarin)
- C. Subcutaneous Low-Molecular-Weight Heparin short-term only
- D. Dual Antiplatelet Therapy (Aspirin plus Clopidogrel)
- E. Oral Aspirin 81 mg daily monotherapy

115. MOCK-115 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 115 · Primary pathophysiological mechanism

58yo obese male presents with retrosternal pressure brought on by exertion, relieved completely within 5 mins of rest. ECG and troponins normal. Primary pathophysiological mechanism?

- A. Acute pericardial sac inflammation
- B. Coronary artery spasm at rest (Prinzmetal angina)
- C. Aortic valve leaflet rupture
- D. Fixed atherosclerotic coronary artery stenosis resulting in demand-supply mismatch during exertion
- E. Acute coronary plaque rupture with occlusive thrombus

ข้อ 116 • Diagnosis

30yo male presents with sharp retrosternal pain worsening on deep inspiration/lying flat, improving sitting forward. ECG shows diffuse ST elevations with PR depressions. Diagnosis?

- A. Acute pericarditis
- B. Pulmonary embolism
- C. Tension pneumothorax
- D. Acute anterior ST-elevation myocardial infarction
- E. Acute aortic dissection

ข้อ 117 • Which drug combination represents essential disease-modifying therapy to reduce mortality

62yo man with HFrEF (LVEF 28%), K⁺ 4.2, Cr 1.1. Which drug combination represents essential disease-modifying therapy to reduce mortality?

- A. ACE inhibitor (or ARNI), Beta-blocker, Mineralocorticoid Receptor Antagonist (MRA), and SGLT2 inhibitor
- B. Isosorbide dinitrate monotherapy
- C. Calcium channel blocker (Amlodipine) and Aspirin
- D. Loop diuretic monotherapy and Digoxin
- E. Flecainide and Warfarin

ข้อ 118 • Additional evaluation performed immediately

55yo man with acute chest pain, ECG shows ST elevation in II, III, aVF, BP 85/55, HR 52, JVD elevated, lungs clear. Additional evaluation performed immediately?

- A. Immediate administration of high-dose IV nitrates and diuretics
- B. Holter monitoring for 24 hours
- C. D-dimer assay before taking further ECGs
- D. Urgent barium swallow study
- E. Right-sided ECG (leads V3R and V4R) to confirm Right Ventricular Infarction

ข้อ 119 • Most appropriate next clinical step

60yo woman presents with atypical chest discomfort. Initial ECG and hs-Troponin T within normal limits. Most appropriate next clinical step?

- A. Repeat ECG and serial Troponin testing in 1–3 hours
- B. Perform an immediate exercise treadmill stress test
- C. Transfer immediately for emergency coronary artery bypass grafting
- D. Discharge home immediately with reassurance
- E. Initiate thrombolytic therapy immediately

120. MOCK-120 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 120 · Immediate treatment of choice

65yo male becomes lightheaded, BP 80/45, HR 170/min, continuous monomorphic wide- complex tachycardia (QRS > 0.12s). Immediate treatment of choice?

- A. Intravenous Adenosine 6 mg rapid bolus
- B. Carotid sinus massage
- C. Intravenous Diltiazem
- D. Synchronized direct-current electrical cardioversion
- E. Oral Digoxin loading dose

121. MOCK-121 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 121 · Management

Asymptomatic 45yo male on routine checkup has ECG with sinus rhythm, prolonged PR interval of 0.24 seconds, all P waves followed by normal QRS. Management?

- A. Intravenous Atropine 1 mg bolus
- B. Emergency electrical cardioversion
- C. Immediate insertion of a temporary transvenous pacemaker
- D. Discontinuation of all physical activity
- E. Observation and reassurance without medical intervention

122. MOCK-122 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 122 · Diagnosis

75yo male with exertional syncope, angina, dyspnea. Harsh crescendo-decrescendo late- systolic ejection murmur at RUSB radiating to carotids, S2 soft. Diagnosis?

- A. Pulmonic stenosis
- B. Aortic regurgitation
- C. Aortic stenosis
- D. Hypertrophic cardiomyopathy
- E. Mitral regurgitation

123. MOCK-123 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 123 · Diagnosis

18yo athlete has harsh systolic murmur left sternal border increasing during Valsalva/standing, decreasing on squatting, family history sudden cardiac death. Diagnosis?

- A. Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)
- B. Mitral Valve Prolapse
- C. Ventricular Septal Defect
- D. Tetralogy of Fallot
- E. Aortic valve stenosis

124. MOCK-124 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 124 · First-line antihypertensive to slow renal disease progression

50yo diabetic with CKD (eGFR 45), BP 148/92, albuminuria 180 mg/g. First-line antihypertensive to slow renal disease progression?

- A. Alpha-blocker (e.g., Doxazosin)
- B. Loop diuretic (e.g., Furosemide)
- C. Beta-blocker (e.g., Atenolol)
- D. Direct vasodilator (e.g., Hydralazine)
- E. ACE inhibitor (e.g., Enalapril) or ARB (e.g., Losartan)

125. MOCK-125 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 125 · Step prior to empiric antibiotics

45yo IVDU presents with fever, new lower left sternal border murmur, splinter hemorrhages, Janeway lesions. Step prior to empiric antibiotics?

- A. Perform a bone marrow biopsy
- B. Obtain three sets of blood cultures from separate venipuncture sites
- C. Administer high-dose intravenous dexamethasone
- D. Obtain a sputum culture for acid-fast bacilli
- E. Perform an immediate CT scan of the chest

126. MOCK-126 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 126 · Diagnostic imaging modality of choice

62yo man presents with sudden severe tearing chest pain radiating to back, BP 180/100 right arm vs 130/70 left arm, mediastinal widening. Diagnostic imaging modality of choice?

- A. Plain lateral spine radiograph
- B. Coronary angiography
- C. Contrast-enhanced CT Angiography of the chest and abdomen
- D. Exercise stress ECG
- E. Transthoracic echocardiography (TTE) alone

127. MOCK-127 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 127 · Immediate initial medical therapy

68yo female with acute dyspnea, orthopnea, pink frothy sputum, BP 160/100, SpO2 82%, wet crackles. Immediate initial medical therapy?

- A. Supplemental oxygen, intravenous Loop Diuretic (Furosemide), and IV Nitroglycerin
- B. Intravenous Digoxin bolus monotherapy
- C. Intravenous fluid bolus 1,000 mL 0.9% Normal Saline
- D. Intravenous Beta-blocker (Metoprolol)
- E. Subcutaneous Low-Molecular-Weight Heparin monotherapy

128. MOCK-128 · Lec M07 · Section 7 · Cardiology

ข้อ 128 • Diagnosis

24yo man presents with fever, dyspnea, diffuse global LV hypokinesis (LVEF 35%), pericardial effusion, elevated Troponin I post Cocksackievirus B infection. Diagnosis?

- A. Hypertrophic cardiomyopathy
- B. Coronary artery disease
- C. Endocardial fibroelastosis
- D. Acute myocarditis
- E. Acute pulmonary embolism

129. MOCK-129 · Lec M08 · Section 8 · Pulmonology

ข้อ 129 • Fundamental pathophysiological mechanism

22yo female with nocturnal cough, wheezing, chest tightness triggered by cold air. Fundamental pathophysiological mechanism?

- A. Permanent destruction of alveolar septa without inflammation
- B. Irreversible pulmonary interstitial fibrosis
- C. Reversible airway hyperresponsiveness and chronic airway inflammation
- D. Non-inflammatory destruction of bronchial cartilage
- E. Pulmonary vascular endothelial proliferation

130. MOCK-130 · Lec M08 · Section 8 · Pulmonology

ข้อ 130 • Diagnosis

35yo baker presents with chest tightness, wheezing worsening during work shifts at bakery, resolving completely on weekends/vacation. Diagnosis?

- A. Chronic obstructive pulmonary disease
- B. Idiopathic pulmonary fibrosis
- C. Hypersensitivity pneumonitis
- D. Byssinosis
- E. Occupational asthma

131. MOCK-131 · Lec M08 · Section 8 · Pulmonology

ข้อ 131 • Which spirometric ratio confirms persistent airflow limitation in COPD

62yo smoker with chronic dyspnea/cough undergoes spirometry. Which spirometric ratio confirms persistent airflow limitation in COPD?

- A. Post-bronchodilator FEV1/FVC > 0.85
- B. Diffusing capacity (DLCO) > 120% predicted
- C. Pre-bronchodilator FVC < 50% predicted
- D. Post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70
- E. Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) variability > 30%

ข้อ 132 · Recommended outpatient empiric oral antibiotic regimen

65yo diabetic man with community-acquired pneumonia, stable vitals, CURB-65 = 0. Recommended outpatient empiric oral antibiotic regimen?

- A. Vancomycin oral capsules
- B. Oseltamivir monotherapy
- C. Metronidazole monotherapy
- D. Ciprofloxacin monotherapy
- E. Amoxicillin-clavulanate plus Azithromycin (or Doxycycline)

ข้อ 133 · Immediate step

25yo stab wound to right chest, severe distress, BP 75/45, HR 130, distended neck veins, trachea shifted left, absent breath sounds right. Immediate step?

- A. Request an urgent portable chest radiograph
- B. Administer intravenous thrombolytics
- C. Perform endotracheal intubation and positive pressure ventilation
- D. Send blood for emergency type and crossmatch
- E. Immediate needle decompression in the 2nd intercostal space at the midclavicular line (or 5th intercostal space anterior axillary line)

ข้อ 134 · Definitive diagnostic imaging modality

58yo woman 4 days post knee replacement develops sudden dyspnea, chest pain, HR 112, SpO2 88%, normal chest X-ray. Definitive diagnostic imaging modality?

- A. Barium swallow study
- B. High-resolution CT (HRCT) of the chest
- C. Plain posteroanterior chest radiograph
- D. Computed Tomography Pulmonary Angiography (CTPA)
- E. Transthoracic echocardiography alone

ข้อ 135 · Correct blood gas interpretation

Obtunded overdose patient, ABG: pH 7.32, PaCO2 60 mmHg, PaO2 70 mmHg, HCO3- 26 mEq/L. Correct blood gas interpretation?

- A. Primary metabolic acidosis with respiratory compensation
- B. Normal arterial blood gas analysis
- C. Acute respiratory acidosis with mild hypoxemia secondary to hypoventilation
- D. Chronic respiratory acidosis with full metabolic compensation
- E. Mixed metabolic acidosis and respiratory alkalosis

ข้อ 136 · Primary mechanism

Alcoholic with poor dentition presents with fever, foul-smelling sputum, thick-walled cavity with air-fluid level in RUL posterior segment. Primary mechanism?

- A. Aspiration of anaerobic oral secretions causing tissue necrosis and lung parenchyma cavitation
- B. Hypersensitivity reaction to inhaled *Aspergillus* spores
- C. Hematogenous seeding of *Staphylococcus aureus* from tricuspid endocarditis
- D. Impaired ciliary dyskinesia causing mucus plugging
- E. Inhalation of silica dust particles

ข้อ 137 · Diagnosis

Pleural fluid analysis reveals milky white fluid, Total Protein 4.5 g/dL, Triglyceride level 340 mg/dL (> 110 mg/dL). Diagnosis?

- A. Chylothorax
- B. Pseudochylothorax
- C. Empyema thoracis
- D. Parapneumonic effusion
- E. Hemothorax

ข้อ 138 · Classification according to Light's criteria

Pleural fluid protein 4.2 g/dL (serum 6.8; ratio 0.62), pleural LDH 450 U/L (serum 500; ratio 0.90). Classification according to Light's criteria?

- A. Artifactual laboratory measurement
- B. Pseudotransudative pleural effusion
- C. Transudative pleural effusion
- D. Exudative pleural effusion
- E. Chylous pleural effusion

ข้อ 139 · Indicated adjustment to inhaled therapy

COPD patient using LAMA continues experiencing 2 exacerbations/yr, blood eosinophils 250 cells/ μ L. Indicated adjustment to inhaled therapy?

- A. Add long-term oral Prednisolone 40 mg daily continuously
- B. Switch to Short-Acting Muscarinic Antagonist (SAMA) monotherapy
- C. Stop all inhalers and start oral Montelukast monotherapy
- D. Initiate long-term intravenous Aminophylline maintenance
- E. Escalate therapy to Long-Acting Beta2-Agonist plus Inhaled Corticosteroid (LABA + ICS) or Triple therapy (LAMA + LABA + ICS)

ข้อ 140 · Which baseline clinical criteria represents definitive indication for Long-Term Home Oxygen

Which baseline clinical criteria represents definitive indication for Long-Term Home Oxygen Therapy (LTOT) in severe stable COPD?

- A. FEV1 < 60% predicted on spirometry
- B. Exertional dyspnea Grade 2 on mMRC scale with normal oxygen saturation
- C. Presence of daytime somnolence alone
- D. Resting arterial PaO₂ of 68 mmHg on room air
- E. Resting arterial PaO₂ ≤ 55 mmHg (or SpO₂ ≤ 88%) on room air

ข้อ 141 · Pneumoconiosis present

Retired insulation installer with progressive dyspnea, HRCT shows pleural plaques and lower lung reticular opacities, biopsy reveals ferruginous bodies. Pneumoconiosis present?

- A. Berylliosis
- B. Silicosis
- C. Asbestosis
- D. Coal worker's pneumoconiosis
- E. Anthracosis

ข้อ 142 · Complication

During therapeutic thoracentesis, 2.2L pleural fluid evacuated rapidly. Patient develops cough, dyspnea, pink frothy sputum, unilateral crackles. Complication?

- A. Tension pneumothorax
- B. Hemothorax
- C. Intercostal nerve laceration
- D. Re-expansion pulmonary edema
- E. Air embolism

ข้อ 143 · Appropriate initial management

Tall thin 20yo male with small right primary spontaneous pneumothorax (< 15%), vitals completely stable, SpO₂ 98%. Appropriate initial management?

- A. Surgical video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) pleurodesis
- B. Immediate needle thoracostomy decompression
- C. Endotracheal intubation and mechanical ventilation
- D. Emergency tube thoracostomy with underwater seal drainage
- E. Observation and supplemental high-flow oxygen administration

ข้อ 144 • Diagnosis

62yo man presents with clubbing, velcro crackles, HRCT shows bibasilar subpleural reticular opacities with honeycombing and traction bronchiectasis. Diagnosis?

- A. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF)
- B. Hypersensitivity pneumonitis
- C. Goodpasture syndrome
- D. Chronic bronchitis
- E. Sarcoidosis

ข้อ 145 • Diagnosis

Trauma victim on ventilator develops severe hypoxemia, bilateral diffuse infiltrates, PCWP < 18 mmHg, PaO₂/FiO₂ = 140 mmHg. Diagnosis?

- A. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
- B. Transfusion-Associated Circulatory Overload
- C. Acute pulmonary embolism
- D. Cardiogenic pulmonary edema
- E. Bilateral lobar pneumonia

ข้อ 146 • Which non-pharmacological intervention has been proven to significantly reduce overall mor

Which non-pharmacological intervention has been proven to significantly reduce overall mortality in patients diagnosed with COPD?

- A. Smoking cessation
- B. High-protein nutritional supplementation alone
- C. Routine influenza vaccination alone
- D. Pulmonary chest physiotherapy alone
- E. Continuous positive airway pressure (CPAP) during daytime

ข้อ 147 • Physiological mechanism explaining action of Spironolactone in cirrhotic ascites

52yo alcoholic cirrhotic with ascites prescribed Spironolactone. Physiological mechanism explaining action of Spironolactone in cirrhotic ascites?

- A. Blockade of vasopressin V₂ receptors in the renal medullary collecting duct
- B. Direct dilation of the afferent renal arterioles
- C. Inhibition of carbonic anhydrase in the proximal convoluted tubule
- D. Inhibition of the Na⁺/K⁺/2Cl⁻ cotransporter in the thick ascending limb of Henle
- E. Competitive antagonism of aldosterone receptors in the late distal tubule and collecting duct, counteracting secondary hyperaldosteronism

148. MOCK-148 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 148 · Hemodynamic changes fundamental in pathogenesis of ascites formation in portal hypertension

Hemodynamic changes fundamental in pathogenesis of ascites formation in portal hypertension?

- A. Decreased sinusoidal hydrostatic pressure
- B. Increased plasma oncotic pressure
- C. Primary suppression of the renin-angiotensin-aldosterone system
- D. Increased intrahepatic vascular resistance accompanied by splanchnic arterial vasodilation
- E. Systemic arterial vasoconstriction leading to renal hyperperfusion

149. MOCK-149 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 149 · Diagnosis

28yo man with acute fatigue, fever, jaundice, AST 1,250, ALT 1,480, IgM anti-HAV positive. Diagnosis?

- A. Acute cholangitis
- B. Autoimmune hepatitis
- C. Wilson disease
- D. Chronic Hepatitis B virus infection
- E. Acute Hepatitis A virus infection

150. MOCK-150 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 150 · Next test to confirm ALP origin from hepatobiliary system

60yo woman with isolated ALP elevation (600 U/L) with normal AST, ALT, Bilirubin. Next test to confirm ALP origin from hepatobiliary system?

- A. Serum Lipase
- B. Serum Amylase
- C. Lactate Dehydrogenase (LDH)
- D. Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) (or 5'-Nucleotidase)
- E. Creatine Kinase MB

151. MOCK-151 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 151 · Central pathogenic mechanism

54yo cirrhotic presents with lethargy, somnolence, asterixis, serum ammonia 160 $\mu\text{mol/L}$. Central pathogenic mechanism?

- A. Accumulation of neurotoxic substances (primarily serum ammonia) due to impaired hepatic detoxification and portosystemic shunting
- B. Acute intracerebral arterial thrombosis
- C. Autoimmune demyelination of the central nervous system
- D. Severe acute hyponatremia
- E. Bacterial invasion of the subarachnoid space

152. MOCK-152 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 152 • Diabetes category

50yo male with chronic calcific pancreatitis presents with elevated HbA1c 6.7%, negative GAD/IA-2 antibodies. Diabetes category?

- A. Idiopathic Type 1B Diabetes
- B. Pancreatogenic Diabetes Mellitus (Type 3c DM / Other specific types)
- C. Gestational Diabetes Mellitus
- D. Type 2 Diabetes Mellitus
- E. Type 1 Diabetes Mellitus

153. MOCK-153 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 153 • Diagnosis

45yo heavy drinker with RUQ pain, fever, jaundice, AST 180, ALT 65 (AST:ALT > 2:1), bilirubin 8.2, WBC 14k. Diagnosis?

- A. Gilbert syndrome
- B. Acute viral hepatitis B
- C. Pyogenic liver abscess
- D. Acute alcoholic hepatitis
- E. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

154. MOCK-154 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 154 • Diagnosis

24yo woman with bloody diarrhea, sigmoidoscopy shows continuous uniform mucosal inflammation extending from rectum proximally, crypt abscesses without granulomas. Diagnosis?

- A. Ulcerative colitis
- B. Crohn's disease
- C. Amoebic colitis
- D. Pseudomembranous colitis
- E. Ischemic colitis

155. MOCK-155 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 155 • Diagnosis

28yo male with non-bloody diarrhea, RLQ pain, weight loss, colonoscopy shows transmural skip lesions in terminal ileum, cobblestoning, non-caseating granulomas. Diagnosis?

- A. Crohn's disease
- B. Irritable Bowel Syndrome
- C. Ulcerative colitis
- D. Celiac disease
- E. Gastrointestinal Tuberculosis

156. MOCK-156 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 156 · Immediate initial management

42yo woman with epigastric pain radiating to back, lipase 1,200 U/L, ultrasound shows gallstones without CBD dilation. Immediate initial management?

- A. Oral administration of pancreatic enzyme supplements
- B. Empiric intravenous broad-spectrum antibiotics
- C. Immediate ERCP with sphincterotomy within 1 hour
- D. Aggressive intravenous fluid resuscitation with isotonic crystalloids (e.g., Lactated Ringer's)
- E. Immediate laparoscopic cholecystectomy

157. MOCK-157 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 157 · Diagnosis

48yo woman with RUQ pain, fever, arrest of inspiration on deep RUQ palpation (Murphy sign+), gallbladder wall 4.5 mm, impacted cystic duct stone. Diagnosis?

- A. Peptic ulcer perforation
- B. Acute hepatitis
- C. Acute cholecystitis
- D. Acute pancreatitis
- E. Acute ascending cholangitis

158. MOCK-158 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 158 · Following initial resuscitation, definitive management step

70yo man with hematemesis, melena, BP 90/60, HR 115. Following initial resuscitation, definitive management step?

- A. Abdominal CT angiography monotherapy
- B. Emergency barium upper GI series
- C. Oral administration of activated charcoal
- D. Exploratory laparotomy without endoscopy
- E. Urgent upper gastrointestinal endoscopy (EGD) within 24 hours

159. MOCK-159 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 159 · First-line antibiotic treatment

Hospitalized patient receiving Ceftriaxone develops profuse foul diarrhea, WBC 18k, stool PCR positive for C. difficile toxin. First-line antibiotic treatment?

- A. Oral Ciprofloxacin
- B. Intravenous Ampicillin
- C. Intravenous Metronidazole monotherapy
- D. Oral Erythromycin
- E. Oral Vancomycin (or oral Fidaxomicin)

160. MOCK-160 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 160 · Recommended initial management approach

40yo woman presents with chronic heartburn and acid regurgitation without alarm symptoms. Recommended initial management approach?

- A. Surgical Nissen fundoplication
- B. Empiric oral clarithromycin and amoxicillin
- C. Immediate upper gastrointestinal endoscopy with biopsy
- D. Empower lifestyle modifications and initiate an 8-week trial of daily oral Proton Pump Inhibitor (PPI)
- E. 24-hour ambulatory esophageal impedance-pH monitoring

161. MOCK-161 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 161 · Appropriate eradication regimen

35yo male with postprandial epigastric pain, urea breath test positive for H. pylori. Appropriate eradication regimen?

- A. Oral Vancomycin for 14 days
- B. Oral Ciprofloxacin and Metronidazole for 7 days
- C. PPI monotherapy for 12 months
- D. Surgical vagotomy and antrectomy
- E. Bismuth quadruple therapy (PPI, Bismuth, Metronidazole, Tetracycline) or Triple therapy (PPI, Amoxicillin, Clarithromycin)

162. MOCK-162 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 162 · Diagnosis

45yo man with progressive dysphagia to solids and liquids, bird's-beak appearance on barium swallow, manometry showing aperistalsis and incomplete LES relaxation. Diagnosis?

- A. Zenker diverticulum
- B. Diffuse esophageal spasm
- C. Achalasia
- D. Reflux esophagitis
- E. Esophageal squamous cell carcinoma

163. MOCK-163 · Lec M09 · Section 9 · Gastroenterology

ข้อ 163 · Definitive management

28yo woman with chronic diarrhea, iron deficiency, anti-tTG IgA positive, duodenal biopsy showing severe villous atrophy. Definitive management?

- A. Oral broad-spectrum antibiotic therapy
- B. Lactose-free diet monotherapy
- C. High-dose systemic corticosteroid therapy
- D. Strict, lifelong gluten-free diet
- E. Subtotal colectomy

ข้อ 164 · IV co-administration on days 1 and 3 proven to significantly reduce renal impairment and m

50yo cirrhotic with SBP started on IV Cefotaxime. IV co-administration on days 1 and 3 proven to significantly reduce renal impairment and mortality?

- A. Intravenous Hydrocortisone
- B. Intravenous Albumin infusion
- C. Intravenous N-acetylcysteine
- D. Intravenous Normal Saline high-volume infusion
- E. Intravenous Furosemide boluses

ข้อ 165 · Renal failure type

58yo man with sepsis develops oliguria, muddy brown granular casts, FeNa 2.8%, urine osmolality 290 mOsm/kg. Renal failure type?

- A. Renal artery thrombosis
- B. Acute glomerulonephritis
- C. Postrenal obstructive uropathy
- D. Acute Tubular Necrosis (Intrinsic AKI)
- E. Prerenal azotemia

ข้อ 166 · Clinical syndrome

20yo male with generalized edema, 24h urine protein 6.5 g/day, albumin 2.1 g/dL, cholesterol 380 mg/dL, oval fat bodies in urine. Clinical syndrome?

- A. Nephritic syndrome
- B. Renal tubular acidosis
- C. Rapidly progressive glomerulonephritis
- D. Acute pyelonephritis
- E. Nephrotic syndrome

ข้อ 167 · Early diabetic nephropathy hemodynamic mechanism initiating disease

Early diabetic nephropathy hemodynamic mechanism initiating disease?

- A. Systemic vasoconstriction decreasing renal blood flow
- B. Glomerular hyperfiltration and intraglomerular hypertension driven by afferent arteriolar vasodilation
- C. Immune complex deposition in the subendothelial space
- D. Direct bacterial infection of the podocytes
- E. Severe afferent arteriolar constriction leading to ischemic glomerular collapse

ข้อ 168 · Diagnosis and first-line treatment

6yo boy with nephrotic syndrome, light microscopy normal, electron microscopy shows diffuse effacement of podocyte foot processes. Diagnosis and first-line treatment?

- A. Membranous Nephropathy; Cyclophosphamide
- B. IgA Nephropathy; ACE inhibitors alone
- C. Lupus Nephritis; Rituximab
- D. Focal Segmental Glomerulosclerosis; Hemodialysis
- E. Minimal Change Disease; Corticosteroid therapy (Prednisolone)

ข้อ 169 · Physiological change causing decline

62yo man with bilateral renal artery stenosis started on Enalapril, serum creatinine rises from 1.2 to 3.2 mg/dL. Physiological change causing decline?

- A. Loss of angiotensin II-mediated efferent arteriolar vasoconstriction, leading to a sudden drop in intraglomerular hydrostatic pressure
- B. Acute allergic interstitial nephritis
- C. Mechanical obstruction of the ureters
- D. Afferent arteriolar vasoconstriction induced by direct drug toxicity
- E. Direct tubular cell necrosis

ข้อ 170 · Appropriate initial fluid therapy

70yo woman with severe vomiting/diarrhea, Na 105 mEq/L, BP 85/50, hypovolemic. Appropriate initial fluid therapy?

- A. Intravenous 5% Dextrose in Water (D5W) rapid infusion
- B. Intravenous furosemide bolus with free water intake
- C. Oral desmopressin (dDAVP) administration
- D. Intravenous 3% Hypertonic Saline bolus (or 0.9% Normal Saline carefully) to raise serum sodium by 4–6 mEq/L rapidly while avoiding overcorrection > 8–10 mEq/L in 24 hours
- E. Fluid restriction alone (< 500 mL/day) without intravenous saline

ข้อ 171 · Preventive measure indicated to minimize Contrast-Induced Nephropathy (CIN)

65yo CKD patient requires contrast CT scan. Preventive measure indicated to minimize Contrast-Induced Nephropathy (CIN)?

- A. Prophylactic hemodialysis immediately prior to CT scanning
- B. Intravenous Furosemide administration immediately before contrast injection
- C. Intravenous 0.9% Normal Saline hydration before and after contrast administration
- D. High-dose oral Potassium Chloride supplementation
- E. Discontinuation of all fluid intake 12 hours prior to scan

172. MOCK-172 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 172 • Diagnosis

7yo boy with tea-colored urine, facial edema, hypertension 2 wks post impetigo, dysmorphic RBCs, RBC casts, low C3, elevated ASO. Biopsy shows subepithelial humps. Diagnosis?

- A. Minimal Change Disease
- B. IgA Nephropathy
- C. Alport Syndrome
- D. Goodpasture Syndrome
- E. Post-Streptococcal Glomerulonephritis (PSGN)

173. MOCK-173 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 173 • Intervention administered FIRST to stabilize cardiac membrane

CKD stage 5 patient with K⁺ 7.2 mEq/L, ECG showing peaked T waves and QRS widening. Intervention administered FIRST to stabilize cardiac membrane?

- A. Intravenous Regular Insulin with 50% Dextrose
- B. Inhaled Salbutamol nebulization
- C. Intravenous Calcium Gluconate (or Calcium Chloride)
- D. Emergency hemodialysis setup
- E. Oral Sodium Polystyrene Sulfonate

174. MOCK-174 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 174 • Initial management strategy

35yo male with severe flank pain radiating to groin, 4-mm stone in left distal ureter without hydronephrosis. Initial management strategy?

- A. Conservative management with analgesia (NSAIDs), fluid hydration, and alpha-blocker therapy (Tamsulosin)
- B. Intravenous broad-spectrum antibiotic therapy alone
- C. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) within 1 hour
- D. Immediate open ureterolithotomy
- E. Emergency percutaneous nephrostomy tube placement

175. MOCK-175 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 175 • Diagnosis

42yo man with hypertension, bilateral flank masses, ultrasound confirms large cysts bilaterally in kidneys and liver. Father died of ruptured cerebral aneurysm. Diagnosis?

- A. Medullary Cystic Kidney Disease
- B. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)
- C. Bilateral Renal Cell Carcinoma
- D. Simple renal cysts
- E. Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD)

176. MOCK-176 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 176 • Diagnosis

22yo male with recurrent painless gross hematuria 1-2 days after URI onset ('synpharyngitic hematuria'), normal complement levels. Biopsy shows mesangial IgA deposition. Diagnosis?

- A. IgA Nephropathy (Berger Disease)
- B. Anti-GBM Disease
- C. Post-Streptococcal Glomerulonephritis
- D. Henoch-Schönlein Purpura
- E. Granulomatosis with Polyangiitis

177. MOCK-177 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 177 • Diagnosis

50yo man with hemoptysis and rapidly progressive renal failure, crescents > 80% glomeruli, IF shows linear IgG along GBM, anti-GBM positive. Diagnosis?

- A. Lupus Nephritis Class IV
- B. Diabetic Glomerulosclerosis
- C. Post-Streptococcal Glomerulonephritis
- D. Granulomatosis with Polyangiitis
- E. Goodpasture Syndrome (Anti-GBM Disease)

178. MOCK-178 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 178 • Diagnosis

Woman taking NSAIDs daily presents with fever, rash, creatinine 2.1 mg/dL, WBC casts, and eosinophiluria. Diagnosis?

- A. Acute Tubular Necrosis (ATN)
- B. Urinary tract obstruction
- C. Renal papillary necrosis
- D. Acute Interstitial Nephritis (AIN)
- E. Glomerulonephritis

179. MOCK-179 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 179 • Secondary condition present

ESRD patient with serum Phosphate 7.8, Calcium 7.9, PTH 650 pg/mL, bone subperiosteal resorption. Secondary condition present?

- A. Secondary Hyperparathyroidism (Renal Osteodystrophy)
- B. Primary Hyperparathyroidism
- C. Paget disease of bone
- D. Hypoparathyroidism
- E. Osteopetrosis

180. MOCK-180 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 180 • Diagnosis

45yo woman with muscle weakness, hypokalemia (K 2.6), metabolic acidosis (HCO_3^- 14), urine pH persistently > 5.5 despite systemic acidemia. Diagnosis?

- A. Type 1 (Distal) Renal Tubular Acidosis
- B. Bartter Syndrome
- C. Diabetic Ketoacidosis
- D. Type 2 (Proximal) Renal Tubular Acidosis
- E. Type 4 Renal Tubular Acidosis

181. MOCK-181 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 181 • Renal structure primarily damaged

Patient receiving Gentamicin develops steady rise in creatinine 1.0 to 2.8 mg/dL over 7 days with preserved urine output. Renal structure primarily damaged?

- A. Main renal artery trunk
- B. Proximal tubular epithelial cells
- C. Medullary collecting ducts
- D. Glomerular podocytes
- E. Loop of Henle thick ascending limb

182. MOCK-182 · Lec M10 · Section 10 · Nephrology

ข้อ 182 • Immediate step

65yo male with anuria for 24 hours, rising creatinine 4.5 mg/dL, ultrasound shows bilateral hydronephrosis and distended bladder. Immediate step?

- A. Emergency hemodialysis setup
- B. Bladder catheterization (placement of Foley catheter)
- C. Renal biopsy
- D. Intravenous fluids 2,000 mL bolus
- E. High-dose intravenous loop diuretic bolus

183. MOCK-183 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 183 • Assay confirming definitive etiology of Graves' disease

32yo woman with heat intolerance, weight loss, tremor, diffuse goiter with bruit, suppressed TSH, elevated Free T4/T3. Assay confirming definitive etiology of Graves' disease?

- A. Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies (TRAb / TSI)
- B. Urinary Free Cortisol
- C. Serum Calcitonin level
- D. Anti-Thyroid Peroxidase (anti-TPO) antibodies alone
- E. Thyroglobulin antibodies (anti-Tg) alone

184. MOCK-184 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 184 · Preferred antithyroid med during 1st trimester to minimize teratogenic risks

28yo pregnant woman at 8 wks gestation diagnosed with Graves' hyperthyroidism. Preferred antithyroid med during 1st trimester to minimize teratogenic risks?

- A. Potassium Iodide saturated solution (SSKI) monotherapy
- B. High-dose Levothyroxine
- C. Propylthiouracil (PTU)
- D. Methimazole (MMI)
- E. Radioactive Iodine-131

185. MOCK-185 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 185 · Comprehensive immediate management for Thyroid Storm

Graves' patient stops meds, develops high fever 39.5°C, HR 155 (AF), delirium, heart failure. Comprehensive immediate management for Thyroid Storm?

- A. Intravenous fluid bolus and Aspirin monotherapy
- B. High-dose Levothyroxine IV and Insulin
- C. Propylthiouracil (or Methimazole), Beta-blocker (Propranolol), Iodine solution (Lugol's), and Hydrocortisone
- D. Radioactive Iodine-131 ablation immediately
- E. Urgent total thyroidectomy within 1 hour

186. MOCK-186 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 186 · Diagnosis

45yo woman with fatigue, weight gain, constipation, lab shows TSH 4.2 mIU/L (normal), Free T4 0.4 ng/dL (low), Free T3 1.2 pg/mL (low). Diagnosis?

- A. Secondary (Central) Hypothyroidism
- B. Euthyroid Sick Syndrome
- C. Subclinical Hypothyroidism
- D. Primary Hypothyroidism (Hashimoto's)
- E. Graves' disease

187. MOCK-187 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 187 · Diagnosis

80yo ICU man with septic shock, TSH 1.5 (normal), Free T4 1.1 (normal), Free T3 0.9 (significantly low). Diagnosis?

- A. Subclinical Hyperthyroidism
- B. Toxic multinodular goiter
- C. Pituitary adenoma
- D. Euthyroid Sick Syndrome (Non-thyroidal illness syndrome)
- E. Primary Hypothyroidism

188. MOCK-188 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 188 · Most sensitive standardized bedside clinical test

Diabetic patient screened for early detection of peripheral sensory neuropathy. Most sensitive standardized bedside clinical test?

- A. Straight leg raise test
- B. Babinski reflex sign
- C. Pinprick testing on the knee
- D. 10-gram Semmes-Weinstein Monofilament examination
- E. Temperature sensation testing on the calf

189. MOCK-189 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 189 · Initial management step

22yo T1DM male with severe nausea, Kussmaul breathing, glucose 420, pH 7.18, HCO₃ 11, anion gap 22, urine ketones positive. Initial management step?

- A. Immediate intravenous bolus of sodium bicarbonate
- B. Intravenous 0.9% Normal Saline fluid hydration
- C. Oral administration of Metformin
- D. High-dose subcutaneous NPH insulin
- E. Immediate administration of broad-spectrum oral antibiotics

190. MOCK-190 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 190 · Primary diagnosis

68yo T2DM male with confusion, glucose 980 mg/dL, serum osmolality 345 mOsm/kg, pH 7.35, HCO₃ 22, urine ketones negative. Primary diagnosis?

- A. Severe Hypoglycemia
- B. Central Diabetes Insipidus
- C. Diabetic Ketoacidosis (DKA)
- D. Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS)
- E. Lactic acidosis

191. MOCK-191 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 191 · Oral agent class providing proven renoprotection and slowing CKD progression

Diabetic with CKD (eGFR 40) and microalbuminuria requires therapy adjustment. Oral agent class providing proven renoprotection and slowing CKD progression?

- A. Alpha-glucosidase inhibitors (e.g., Acarbose)
- B. SGLT2 Inhibitors (e.g., Empagliflozin, Dapagliflozin)
- C. Sulfonylureas (e.g., Glibenclamide)
- D. Meglitinides (e.g., Repaglinide)
- E. Thiazolidinediones (e.g., Pioglitazone)

192. MOCK-192 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 192 · Entity encompassing combination of organ-specific autoimmune disorders

28yo woman with T1DM over 3 years develops Hashimoto thyroiditis and vitiligo. Entity encompassing combination of organ-specific autoimmune disorders?

- A. Cushing's Disease
- B. Polyglandular Autoimmune Syndrome
- C. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 (MEN 1)
- D. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A (MEN 2A)
- E. Metabolic Syndrome

193. MOCK-193 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 193 · Best initial screening test for Cushing's syndrome

40yo woman with central obesity, moon facies, buffalo hump, purple striae, BP 150/95. Best initial screening test for Cushing's syndrome?

- A. Random serum cortisol level
- B. 24-hour Urinary Free Cortisol measurement (or Overnight 1-mg Dexamethasone Suppression Test)
- C. Serum Aldosterone-to-Renin ratio
- D. Abdominal CT scan alone
- E. Morning plasma ACTH level alone

194. MOCK-194 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 194 · Diagnostic test confirming Addison's disease

35yo female with fatigue, weight loss, hyperpigmentation of oral mucosa/palmar creases, BP 85/50, Na 128, K 5.8, low cortisol. Diagnostic test confirming Addison's disease?

- A. Oral glucose tolerance test
- B. High-dose dexamethasone suppression test
- C. Water deprivation test
- D. Cosyntropin (ACTH) Stimulation Test
- E. Insulin tolerance test monotherapy

195. MOCK-195 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 195 · Test confirming diagnosis of Acromegaly

45yo male with enlargement of hands/feet, prognathism, coarse facial features, high IGF- 1. Test confirming diagnosis of Acromegaly?

- A. Fasting blood glucose measurement alone
- B. Serum Prolactin level alone
- C. TSH response to TRH injection
- D. Cortisolemia suppression following dexamethasone
- E. Failure of Growth Hormone (GH) suppression following an Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)

196. MOCK-196 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 196 • Diagnosis

50yo man with recurrent calcium kidney stones, Ca 11.8 mg/dL (high), Phos 2.1 (low), PTH 140 pg/mL (high), parathyroid adenoma on ultrasound. Diagnosis?

- A. Tertiary Hyperparathyroidism
- B. Malignancy-associated hypercalcemia
- C. Secondary Hyperparathyroidism
- D. Primary Hyperparathyroidism
- E. Familial Hypocalciuric Hypercalcemia

197. MOCK-197 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 197 • First-line pharmacologic class

28yo woman with amenorrhea, galactorrhea, bitemporal hemianopsia, prolactin 280 ng/mL, MRI 1.2-cm macroadenoma. First-line pharmacologic class?

- A. Dopamine Agonist (e.g., Cabergoline or Bromocriptine)
- B. Radiation therapy monotherapy
- C. Somatostatin Analog (e.g., Octreotide)
- D. Recombinant Human Growth Hormone
- E. High-dose oral Corticosteroids

198. MOCK-198 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 198 • Immediate management

30yo woman 24h post total thyroidectomy develops paresthesias, muscle cramps, positive Chvostek sign, serum Ca 6.2 mg/dL. Immediate management?

- A. Oral Levothyroxine 200 mcg
- B. Oral Furosemide
- C. Intravenous Calcium Gluconate
- D. Intravenous Potassium Chloride
- E. Subcutaneous Calcitonin

199. MOCK-199 · Lec M11 · Section 11 · Endocrinology

ข้อ 199 • Drug class initiated BEFORE surgery

42yo male with paroxysmal hypertension, headache, sweating, palpitations, metanephrines elevated 5x, 4-cm adrenal medulla mass. Drug class initiated BEFORE surgery?

- A. Beta-adrenergic blocker (e.g., Propranolol) monotherapy first
- B. Alpha-adrenergic blocker (e.g., Phenoxybenzamine or Doxazosin) prior to beta-blocker initiation
- C. Intravenous Nitroglycerin infusion continuously for 2 weeks
- D. ACE inhibitor (e.g., Enalapril) monotherapy
- E. Loop diuretic (e.g., Furosemide) high-dose

ข้อ 200 · Primary diagnosis

48yo male with resistant hypertension, suppressed K⁺ 2.8 mEq/L, elevated Aldosterone 32 ng/dL, suppressed Renin < 0.5, ARR > 30. Primary diagnosis?

- A. Renal Artery Stenosis
- B. Essential Hypertension
- C. Cushing's Syndrome ส่วนเฉลยและคำอธิบายคำตอบ (
- D. Pheochromocytoma
- E. Primary Aldosteronism (Conn Syndrome)

Part 2 · MEQ — ข้อเขียนเคสต่อเนื่อง (0 ชุด)

Part 3 · OSCE / SAQ — สถานีละ 5 นาที (0 สถานี)

ส่วนที่ 2 • เฉลยและคำอธิบาย

อธิบายกลไกเป็นแกน พร้อมเหตุผลการตัดตัวเลือกที่เหลือทิ้ง

Part 1 • MCQ — เฉลย

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
1	MOCK-001	D	ข้อ 1 · The most appropriate management plan
2	MOCK-002	A	ข้อ 2 · The drug of choice for this patient
3	MOCK-003	B	ข้อ 3 · The most appropriate treatment
4	MOCK-004	A	ข้อ 4 · The most appropriate initial treatment
5	MOCK-005	C	ข้อ 5 · The most likely diagnosis
6	MOCK-006	E	ข้อ 6 · The most appropriate management
7	MOCK-007	B	ข้อ 7 · The recommended induction therapy
8	MOCK-008	D	ข้อ 8 · The most appropriate management for the sexual partner
9	MOCK-009	C	ข้อ 9 · Which of the following radical cure drug regimens should be prescribed
10	MOCK-010	D	ข้อ 10 · The primary step in management
11	MOCK-011	C	ข้อ 11 · The most appropriate intervention
12	MOCK-012	B	ข้อ 12 · The empiric antibiotic of choice
13	MOCK-013	D	ข้อ 13 · The most urgent intervention
14	MOCK-014	B	ข้อ 14 · Which of the following single-tablet regimens represents the preferred first-line ART
15	MOCK-015	D	ข้อ 15 · The most appropriate definitive antibiotic treatment
16	MOCK-016	A	ข้อ 16 · The most likely pathogen
17	MOCK-017	D	ข้อ 17 · Which of the following post-exposure prophylaxis regimens is indicated for the roommate
18	MOCK-018	D	ข้อ 18 · The most appropriate management
19	MOCK-019	B	ข้อ 19 · The best initial empiric antibiotic regimen
20	MOCK-020	E	ข้อ 20 · The most likely organism
21	MOCK-021	C	ข้อ 21 · The primary localized treatment of choice
22	MOCK-022	E	ข้อ 22 · The most appropriate diagnostic procedure
23	MOCK-023	A	ข้อ 23 · The primary definitive treatment strategy
24	MOCK-024	D	ข้อ 24 · Which of the following staging investigations is necessary prior to definitive management
25	MOCK-025	A	ข้อ 25 · Which of the following systemic adjuvant therapies is indicated
26	MOCK-026	B	ข้อ 26 · The correct explanation
27	MOCK-027	B	ข้อ 27 · Which of the following viral agents is recognized as the leading cause of hepatocellular c
28	MOCK-028	B	ข้อ 28 · The most likely diagnosis
29	MOCK-029	A	ข้อ 29 · Exposure to which substance is the primary etiologic factor

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
30	MOCK-030	B	ข้อ 30 · The most likely diagnosis
31	MOCK-031	C	ข้อ 31 · The primary mechanism of pleural effusion accumulation in this patient
32	MOCK-032	E	ข้อ 32 · The diagnostic test of choice
33	MOCK-033	A	ข้อ 33 · Which of the following modalities is recommended by international clinical guidelines
34	MOCK-034	C	ข้อ 34 · The most likely diagnosis
35	MOCK-035	C	ข้อ 35 · Which malignancy is most strongly suggested
36	MOCK-036	B	ข้อ 36 · The diagnosis
37	MOCK-037	D	ข้อ 37 · Which thyroid malignancy is indicated
38	MOCK-038	A	ข้อ 38 · Which pharmacologic class reduces skeletal-related events
39	MOCK-039	E	ข้อ 39 · Which laboratory serum profile is diagnostic of iron deficiency anemia
40	MOCK-040	C	ข้อ 40 · Which is the initial first-line treatment
41	MOCK-041	A	ข้อ 41 · Which mechanism accounts for these findings
42	MOCK-042	D	ข้อ 42 · Which testing set confirms von Willebrand Disease (vWD)
43	MOCK-043	E	ข้อ 43 · Which characterizes this defect
44	MOCK-044	E	ข้อ 44 · Which is the most likely diagnosis
45	MOCK-045	D	ข้อ 45 · Which is the diagnosis
46	MOCK-046	E	ข้อ 46 · What is the immediate step
47	MOCK-047	A	ข้อ 47 · Mechanism of this reaction
48	MOCK-048	C	ข้อ 48 · Which is the diagnosis
49	MOCK-049	C	ข้อ 49 · What explains this coagulopathy
50	MOCK-050	E	ข้อ 50 · Which enzyme deficiency
51	MOCK-051	B	ข้อ 51 · Primary diagnosis
52	MOCK-052	C	ข้อ 52 · Long-term management
53	MOCK-053	B	ข้อ 53 · Which agent rapidly corrects uremic bleeding prior to procedure
54	MOCK-054	B	ข้อ 54 · Main mechanism responsible
55	MOCK-055	D	ข้อ 55 · Diagnosis
56	MOCK-056	E	ข้อ 56 · Diagnosis
57	MOCK-057	B	ข้อ 57 · Diagnosis
58	MOCK-058	C	ข้อ 58 · Diagnosis
59	MOCK-059	B	ข้อ 59 · Diagnosis
60	MOCK-060	E	ข้อ 60 · Diagnosis
61	MOCK-061	D	ข้อ 61 · Primary pathogen
62	MOCK-062	B	ข้อ 62 · Most appropriate antiviral therapy
63	MOCK-063	D	ข้อ 63 · Recommended first-line topical treatment
64	MOCK-064	A	ข้อ 64 · Most effective oral treatment regimen
65	MOCK-065	A	ข้อ 65 · Responsible toxin
66	MOCK-066	C	ข้อ 66 · Diagnosis

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
67	MOCK-067	A	ข้อ 67 · Underlying immunopathogenesis
68	MOCK-068	C	ข้อ 68 · Diagnosis
69	MOCK-069	B	ข้อ 69 · Pathogenic autoantibodies
70	MOCK-070	A	ข้อ 70 · Treatment of choice
71	MOCK-071	D	ข้อ 71 · Acnes
72	MOCK-072	A	ข้อ 72 · Causative organism
73	MOCK-073	C	ข้อ 73 · Diagnosis
74	MOCK-074	B	ข้อ 74 · Most effective topical therapy
75	MOCK-075	D	ข้อ 75 · Disease-modifying agent initiated in all SLE patients
76	MOCK-076	C	ข้อ 76 · Diagnosis
77	MOCK-077	D	ข้อ 77 · Diagnosis
78	MOCK-078	D	ข้อ 78 · Acute management of choice
79	MOCK-079	E	ข้อ 79 · Responsible crystal type
80	MOCK-080	E	ข้อ 80 · Diagnosis
81	MOCK-081	B	ข้อ 81 · First-line pharmacotherapy
82	MOCK-082	B	ข้อ 82 · Anchor first-line DMARD
83	MOCK-083	D	ข้อ 83 · Specific clinical entity
84	MOCK-084	C	ข้อ 84 · Diagnosis
85	MOCK-085	E	ข้อ 85 · Diagnosis
86	MOCK-086	C	ข้อ 86 · Diagnosis
87	MOCK-087	A	ข้อ 87 · Diagnosis
88	MOCK-088	E	ข้อ 88 · Most urgent step to prevent permanent vision loss
89	MOCK-089	D	ข้อ 89 · Diagnosis
90	MOCK-090	D	ข้อ 90 · Immediate plan
91	MOCK-091	C	ข้อ 91 · Diagnosis
92	MOCK-092	A	ข้อ 92 · Prior to initiating urate-lowering therapy, which co-prescription is necessary to prevent
93	MOCK-093	D	ข้อ 93 · Most appropriate acute intervention
94	MOCK-094	D	ข้อ 94 · Anatomical lesion located
95	MOCK-095	A	ข้อ 95 · Which structure is directly compressed against tentorium cerebelli
96	MOCK-096	E	ข้อ 96 · Neuroanatomical localization best explaining altered sensorium
97	MOCK-097	D	ข้อ 97 · Drug of choice
98	MOCK-098	D	ข้อ 98 · Diagnosis
99	MOCK-099	D	ข้อ 99 · Single most critical historical element required to determine eligibility for IV thromboly
100	MOCK-100	E	ข้อ 100 · Diagnosis
101	MOCK-101	B	ข้อ 101 · Diagnosis
102	MOCK-102	C	ข้อ 102 · Diagnosis

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
103	MOCK-103	B	ข้อ 103 · Diagnosis
104	MOCK-104	A	ข้อ 104 · Which neurotransmitter deficiency in substantia nigra pars compacta
105	MOCK-105	E	ข้อ 105 · Action required prior to performing lumbar puncture
106	MOCK-106	B	ข้อ 106 · Diagnosis
107	MOCK-107	B	ข้อ 107 · Effective acute abortive treatment
108	MOCK-108	C	ข้อ 108 · Pharmacologic agent indicated for acute abortive therapy
109	MOCK-109	C	ข้อ 109 · Diagnosis
110	MOCK-110	D	ข้อ 110 · First-line intravenous medication
111	MOCK-111	A	ข้อ 111 · Diagnosis
112	MOCK-112	B	ข้อ 112 · Hemodynamic mechanism causing shock
113	MOCK-113	C	ข้อ 113 · AV block type
114	MOCK-114	B	ข้อ 114 · Most appropriate long-term antithrombotic management
115	MOCK-115	D	ข้อ 115 · Primary pathophysiological mechanism
116	MOCK-116	A	ข้อ 116 · Diagnosis
117	MOCK-117	A	ข้อ 117 · Which drug combination represents essential disease-modifying therapy to reduce mortality
118	MOCK-118	E	ข้อ 118 · Additional evaluation performed immediately
119	MOCK-119	A	ข้อ 119 · Most appropriate next clinical step
120	MOCK-120	D	ข้อ 120 · Immediate treatment of choice
121	MOCK-121	E	ข้อ 121 · Management
122	MOCK-122	C	ข้อ 122 · Diagnosis
123	MOCK-123	A	ข้อ 123 · Diagnosis
124	MOCK-124	E	ข้อ 124 · First-line antihypertensive to slow renal disease progression
125	MOCK-125	B	ข้อ 125 · Step prior to empiric antibiotics
126	MOCK-126	C	ข้อ 126 · Diagnostic imaging modality of choice
127	MOCK-127	A	ข้อ 127 · Immediate initial medical therapy
128	MOCK-128	D	ข้อ 128 · Diagnosis
129	MOCK-129	C	ข้อ 129 · Fundamental pathophysiological mechanism
130	MOCK-130	E	ข้อ 130 · Diagnosis
131	MOCK-131	D	ข้อ 131 · Which spirometric ratio confirms persistent airflow limitation in COPD
132	MOCK-132	E	ข้อ 132 · Recommended outpatient empiric oral antibiotic regimen
133	MOCK-133	E	ข้อ 133 · Immediate step
134	MOCK-134	D	ข้อ 134 · Definitive diagnostic imaging modality
135	MOCK-135	C	ข้อ 135 · Correct blood gas interpretation
136	MOCK-136	A	ข้อ 136 · Primary mechanism
137	MOCK-137	A	ข้อ 137 · Diagnosis
138	MOCK-138	D	ข้อ 138 · Classification according to Light's criteria
139	MOCK-139	E	ข้อ 139 · Indicated adjustment to inhaled therapy

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
140	MOCK-140	E	ข้อ 140 · Which baseline clinical criteria represents definitive indication for Long-Term Home Oxyge
141	MOCK-141	C	ข้อ 141 · Pneumoconiosis present
142	MOCK-142	D	ข้อ 142 · Complication
143	MOCK-143	E	ข้อ 143 · Appropriate initial management
144	MOCK-144	A	ข้อ 144 · Diagnosis
145	MOCK-145	A	ข้อ 145 · Diagnosis
146	MOCK-146	A	ข้อ 146 · Which non-pharmacological intervention has been proven to significantly reduce overall mor
147	MOCK-147	E	ข้อ 147 · Physiological mechanism explaining action of Spironolactone in cirrhotic ascites
148	MOCK-148	D	ข้อ 148 · Hemodynamic changes fundamental in pathogenesis of ascites formation in portal hypertensio
149	MOCK-149	E	ข้อ 149 · Diagnosis
150	MOCK-150	D	ข้อ 150 · Next test to confirm ALP origin from hepatobiliary system
151	MOCK-151	A	ข้อ 151 · Central pathogenic mechanism
152	MOCK-152	B	ข้อ 152 · Diabetes category
153	MOCK-153	D	ข้อ 153 · Diagnosis
154	MOCK-154	A	ข้อ 154 · Diagnosis
155	MOCK-155	A	ข้อ 155 · Diagnosis
156	MOCK-156	D	ข้อ 156 · Immediate initial management
157	MOCK-157	C	ข้อ 157 · Diagnosis
158	MOCK-158	E	ข้อ 158 · Following initial resuscitation, definitive management step
159	MOCK-159	E	ข้อ 159 · First-line antibiotic treatment
160	MOCK-160	D	ข้อ 160 · Recommended initial management approach
161	MOCK-161	E	ข้อ 161 · Appropriate eradication regimen
162	MOCK-162	C	ข้อ 162 · Diagnosis
163	MOCK-163	D	ข้อ 163 · Definitive management
164	MOCK-164	B	ข้อ 164 · IV co-administration on days 1 and 3 proven to significantly reduce renal impairment and m
165	MOCK-165	D	ข้อ 165 · Renal failure type
166	MOCK-166	E	ข้อ 166 · Clinical syndrome
167	MOCK-167	B	ข้อ 167 · Early diabetic nephropathy hemodynamic mechanism initiating disease
168	MOCK-168	E	ข้อ 168 · Diagnosis and first-line treatment
169	MOCK-169	A	ข้อ 169 · Physiological change causing decline
170	MOCK-170	D	ข้อ 170 · Appropriate initial fluid therapy
171	MOCK-171	C	ข้อ 171 · Preventive measure indicated to minimize Contrast-Induced Nephropathy (CIN)
172	MOCK-172	E	ข้อ 172 · Diagnosis

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
173	MOCK-173	C	ข้อ 173 · Intervention administered FIRST to stabilize cardiac membrane
174	MOCK-174	A	ข้อ 174 · Initial management strategy
175	MOCK-175	B	ข้อ 175 · Diagnosis
176	MOCK-176	A	ข้อ 176 · Diagnosis
177	MOCK-177	E	ข้อ 177 · Diagnosis
178	MOCK-178	D	ข้อ 178 · Diagnosis
179	MOCK-179	A	ข้อ 179 · Secondary condition present
180	MOCK-180	A	ข้อ 180 · Diagnosis
181	MOCK-181	B	ข้อ 181 · Renal structure primarily damaged
182	MOCK-182	B	ข้อ 182 · Immediate step
183	MOCK-183	A	ข้อ 183 · Assay confirming definitive etiology of Graves' disease
184	MOCK-184	C	ข้อ 184 · Preferred antithyroid med during 1st trimester to minimize teratogenic risks
185	MOCK-185	C	ข้อ 185 · Comprehensive immediate management for Thyroid Storm
186	MOCK-186	A	ข้อ 186 · Diagnosis
187	MOCK-187	D	ข้อ 187 · Diagnosis
188	MOCK-188	D	ข้อ 188 · Most sensitive standardized bedside clinical test
189	MOCK-189	B	ข้อ 189 · Initial management step
190	MOCK-190	D	ข้อ 190 · Primary diagnosis
191	MOCK-191	B	ข้อ 191 · Oral agent class providing proven renoprotection and slowing CKD progression
192	MOCK-192	B	ข้อ 192 · Entity encompassing combination of organ-specific autoimmune disorders
193	MOCK-193	B	ข้อ 193 · Best initial screening test for Cushing's syndrome
194	MOCK-194	D	ข้อ 194 · Diagnostic test confirming Addison's disease
195	MOCK-195	E	ข้อ 195 · Test confirming diagnosis of Acromegaly
196	MOCK-196	D	ข้อ 196 · Diagnosis
197	MOCK-197	A	ข้อ 197 · First-line pharmacologic class
198	MOCK-198	C	ข้อ 198 · Immediate management
199	MOCK-199	B	ข้อ 199 · Drug class initiated BEFORE surgery
200	MOCK-200	E	ข้อ 200 · Primary diagnosis

1. ตอบ D ข้อ 1 · The most appropriate management plan MOCK-001 · Lec M01

ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับ Dengue fever (ไข้เลือดออกเดงกี) ที่ไม่มีการเลือดออกรุนแรง การดูแลรักษาที่ถูกต้องคือการให้สารน้ำทดแทน (IV fluids) และติดตาม serial hematocrit และสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด ไม่มีความจำเป็นต้องให้เกล็ดเลือดหากไม่มี active bleeding รุนแรง

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 1 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

2. ตอบ A ข้อ 2 · The drug of choice for this patient MOCK-002 · Lec M01

ลักษณะย้อม Gram พบ weakly Gram-positive branching filamentous rods และย้อม modified acid-fast (Kinyoun) ให้ผลบวก ในผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็นลักษณะเฉพาะของ Nocardia infection ยาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก (Drug of choice) คือ Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 2 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

3. ตอบ B ข้อ 3 · The most appropriate treatment MOCK-003 · Lec M01

รอยแผล painless black necrotic ulcer with erythematous halo (Eschar) ร่วมกับประวัติเดินป่า มีไข้สูง ปวดศีรษะ และต่อมน้ำเหลืองโต เป็นลักษณะเฉพาะของ Scrub typhus (เกิดจาก Orientia tsutsugamushi) ยารักษาอันดับแรกคือ Oral Doxycycline

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 3 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

4. ตอบ A ข้อ 4 · The most appropriate initial treatment MOCK-004 · Lec M01

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 < 200 cells/ μ L ร่วมกับปอดอักเสบแบบ diffuse ground-glass opacities และมีภาวะ hypoxemia (SpO₂ 86%, PaO₂ < 70 mmHg) นึกถึง Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) การรักษาคือ TMP-SMX ร่วมกับ corticosteroid (Prednisolone) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากปอดอักเสบสืบสน

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 4 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

5. ตอบ C ข้อ 5 · The most likely diagnosis MOCK-005 · Lec M01

อาการไข้สูง ผื่น และปวดข้อรุนแรงหลายข้อแบบ incapacitated polyarthralgia โดยที่ผลตรวจ Dengue NS1 ให้ผลลบ เป็นลักษณะคลาสสิกของ Chikungunya fever ซึ่งเกิดจาก Chikungunya virus

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 5 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

6. ตอบ E ข้อ 6 · The most appropriate management MOCK-006 · Lec M01

เจ็บคอและไข้ต่ำในเด็ก โดยไม่มี tonsillar exudate, palatal petechiae หรือต่อมน้ำเหลืองโต อาการเข้าได้กับ viral pharyngitis (Centor score ต่ำ) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ การรักษาที่เหมาะสมคือการบรรเทาอาการ (Symptomatic relief)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 6 · Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

7. ตอบ B ข้อ 7 • The recommended induction therapy MOCK-007 • Lec M01

ผลย้อม CSF India ink พบ encapsulated budding yeast cells วินิจฉัยเป็น Cryptococcal meningitis ในผู้ป่วย HIV การรักษาในระยะ Induction therapy ที่แนะนำตามมาตรฐานคือ Liposomal Amphotericin B ร่วมกับ Flucytosine เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 7 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

8. ตอบ D ข้อ 8 • The most appropriate management for the sexual partner MOCK-008 • Lec M01

คู่นอนของผู้ป่วย early latent syphilis ที่มีเพศสัมพันธ์ภายใน 90 วัน ควรได้รับการรักษาเชิงป้องกัน (Epidemiologic treatment) ทันที แม้จะไม่มีอาการและผล RPR เป็นลบ โดยให้ Benzathine Penicillin G 2.4 million units IM ฉีดเข็มเดียว

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 8 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

9. ตอบ ข้อ 9 • Which of the following radical cure drug regimens should be prescribed C MOCK-009 • Lec M01

เชื้อ Plasmodium vivax มีระยะ hypnozoite อยู่ในตับ การรักษาเพื่อกวาดล้างเชื้อให้หายขาด (Radical cure) ต้องใช้ Chloroquine เพื่อกำจัดระยะในเลือด ร่วมกับ Primaquine เป็นเวลา 14 วันเพื่อกำจัดระยะ hypnozoite ในตับ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 9 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

10. ตอบ D ข้อ 10 • The primary step in management MOCK-010 • Lec M01

อุจจาระร่วงเป็นน้ำใสคล้ายน้ำข้าวข้าว (Rice-water stool) ร่วมกับภาวะช็อก dehydration จาก Cholera (Vibrio cholerae) หัวใจสำคัญของการรักษาอันดับแรกคือการให้สารน้ำทดแทนทางหลอดเลือดดำทันที (IV isotonic crystalloids)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 10 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.1 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

11. **ตอบ C** ข้อ 11 • The most appropriate intervention

MOCK-011 • Lec M01

ภาวะ Asymptomatic bacteriuria ในหญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเสมอเพื่อป้องกัน pyelonephritis ยาที่ปลอดภัยในไตรมาสแรก ได้แก่ Amoxicillin หรือ Nitrofurantoin เป็นเวลา 5-7 วัน (หลีกเลี่ยง Fluoroquinolones และ TMP-SMX ในไตรมาสแรก/สาม)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 11 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

12. **ตอบ B** ข้อ 12 • The empiric antibiotic of choice

MOCK-012 • Lec M01

ผลตรวจน้ำในช่องท้องพบ PMN $\geq 250/\mu\text{L}$ ในผู้ป่วยตับแข็ง เข้าได้กับ Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) ยาปฏิชีวนะประเดิม (Empiric antibiotic) ที่เป็นตัวเลือกแรกคือ 3rd generation cephalosporin เช่น IV Cefotaxime หรือ Ceftriaxone

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 12 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

13. **ตอบ D** ข้อ 13 • The most urgent intervention

MOCK-013 • Lec M01

อาการใช้สับสน ชัก Focal ร่วมกับรอยโรคใน temporal lobe บน MRI และ CSF มี lymphocyte และ RBC เด่น เข้าได้กับ Herpes simplex encephalitis (HSE) ต้องรีบให้ IV Acyclovir ทันทีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการทางสมอง

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 13 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

14. **ตอบ B** ข้อ 14 • Which of the following single-tablet regimens represents the preferred first-line ART

MOCK-014 • Lec M01

สูตรยาต้านไวรัส HIV เริ่มต้นสูตรแรกที่เหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติสากลและประเทศไทยในปัจจุบันคือสูตรที่มี Integrase Strand Transfer Inhibitor (INSTI) เป็นหลัก ได้แก่ Tenofovir / Lamivudine / Dolutegravir (TLD)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 14 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

15. ตอบ D ข้อ 15 • The most appropriate definitive antibiotic treatment MOCK-015 • Lec M01

เสมหะสีสนิมเหล็ก (Rust-colored sputum) ร่วมกับ Gram-positive lancet-shaped diplococci คือลักษณะเฉพาะของ *Streptococcus pneumoniae* (Pneumococcus) ยาปฏิชีวนะรักษาปอดอักเสบจากเชื้อนี้คือ IV Ceftriaxone หรือ Penicillin

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 15 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

16. ตอบ A ข้อ 16 • The most likely pathogen MOCK-016 • Lec M01

ข้ออักเสบเป็นหนองในวัยรุ่น/ผู้ใหญ่ตอนต้น ร่วมกับมีผื่น necrotic pustules บนผิวหนัง เข้าได้กับ Disseminated Gonococcal Infection (DGI) เชื้อก่อเหตุคือ *Neisseria gonorrhoeae*

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 16 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

17. ข้อ 17 • Which of the following post-exposure prophylaxis regimens is indicated for the roommate MOCK-017 • Lec M01

ผู้สัมผัสใกล้ชิดระดับสูง (Close contacts เช่น เพื่อนร่วมห้องพัก) ของผู้ป่วย Meningococcal meningitis ต้องได้รับยาปฏิชีวนะป้องกัน

post-exposure prophylaxis ทันทียาที่ใช้ได้แก่ Oral Rifampin (หรือ Ciprofloxacin หรือ Ceftriaxone IM)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 17 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

18. ตอบ D ข้อ 18 • The most appropriate management MOCK-018 • Lec M01

พบบริเวณ Ileocecum มี granuloma แบบ caseous necrosis ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ Gastrointestinal Tuberculosis (วัณโรคระบบทางเดินอาหาร) การรักษาคือให้ยารักษาวัณโรค 4 ตัวมาตรฐาน (HRZE)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 18 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

19. ตอบ B ข้อ 19 • The best initial empiric antibiotic regimen MOCK-019 • Lec M01

ปวดเอว ไช้สูง กดเจ็บ CVA และพบ WBC casts ในปัสสาวะ แสดงถึงภาวะ Acute pyelonephritis (กรวยไตอักเสบติดเชื้อเฉียบพลัน)

ยาปฏิชีวนะประเดิมที่เหมาะสมคือ IV Ceftriaxone (Nitrofurantoin ไม่ขยายผลถึงเนื้อไต)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 19 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62

20. ตอบ E ข้อ 20 • The most likely organism MOCK-020 • Lec M01

แบคทีเรียแกรมลบ หมักน้ำตาลแลคโตส (Lactose-fermenting) และสร้างแคปซูลหนาแบบเมือก (Muroid capsule) ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลคือ *Klebsiella pneumoniae*

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 20 • Infectious Disease

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.1** โรคติดเชื้อและโรคปรสิต (ทั้งหมด) — 2.3.1 Infectious and parasitic diseases หน้า 62
-

21. ตอบ C ข้อ 21 • The primary localized treatment of choice MOCK-021 • Lec M02

Basal cell carcinoma (BCC) มีลักษณะ pearly papule with telangiectasia

การรักษามาตรฐานอันดับแรกสำหรับรอยโรคเฉพาะที่คือการผ่าตัดออกโดยตัดขอบให้กว้างพอจนได้ขอบปลอดเชื้อ (Surgical excision with clear margins)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 21 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

22. ตอบ E ข้อ 22 • The most appropriate diagnostic procedure MOCK-022 • Lec M02

อาการกลืนลำบากแบบเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ (Progressive dysphagia) จากของแข็งไปของเหลว ในผู้สูบบุหรี่จัด สงสัยมะเร็งหลอดอาหาร

การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่ดีที่สุดคือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนร่วมกับตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Upper GI endoscopy with tissue biopsy)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 22 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

23. ตอบ A ข้อ 23 • The primary definitive treatment strategy MOCK-023 • Lec M02

Small cell lung carcinoma (SCLC) มักลุกลามเร็วและมักตอบสนองดีต่อเคมีบำบัด การรักษาหลักคือ Systemic chemotherapy (สูตร Platinum ร่วมกับ Etoposide) โดยการผ่าตัดมักไม่เหมาะเนื่องจากเป็นก้อนตำแหน่งกลางและลุกลามรวดเร็ว

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 23 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63

24. ข้อ 24 · Which of the following staging investigations is necessary prior to definitive management MOCK-024 · Lec M02

การจัดระยะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer staging) ก่อนวางแผนการรักษา จำเป็นต้องทำ Contrast-enhanced CT chest, abdomen, and pelvis เพื่อประเมินการลุกลามเฉพาะที่และการแพร่กระจายไปยังตับและปอด

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 24 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

25. ข้อ 25 · Which of the following systemic adjuvant therapies is indicated MOCK-025 · Lec M02

มะเร็งเต้านมชนิด ER+ และ PR+ ที่ผ่าตัดแล้วเสร็จ มีข้อบ่งชี้การให้การรักษาเสริมด้วยฮอร์โมน (Adjuvant endocrine therapy) เช่น

Tamoxifen หรือ Aromatase Inhibitor เพื่อลดการกลับเป็นซ้ำ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 25 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

26. ข้อ 26 · The correct explanation MOCK-026 · Lec M02

วัตถุประสงค์หลักของการให้ยาเคมีบำบัดเสริม (Adjuvant chemotherapy) หลังผ่าตัด คือการกำจัดเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่

(Microscopic residual disease) เพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำและเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 26 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

27. ข้อ 27 · Which of the following viral agents is recognized as the leading cause of hepatocellular carcinoma MOCK-027 · Lec M02

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (Chronic Hepatitis B Virus / HBV) เป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งของการเกิดมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma / HCC) ทั่วโลก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 27 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63

28. ตอบ B ข้อ 28 • The most likely diagnosis

MOCK-028 • Lec M02

รอยโรคในสมองลักษณะ well-circumscribed, ring-enhancing lesion ร่วมกับรอยต่อระหว่าง cortex และ white matter ในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งเต้านม เข้าได้มากที่สุดกับ Brain metastasis (มะเร็งแพร่กระจายมาสมอง)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 28 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

29. ตอบ ข้อ 29 • Exposure to which substance is the primary etiologic factor

MOCK-029 • Lec M02

Malignant mesothelioma (มะเร็งเยื่อหุ้มปอด) มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการสัมผัสแร่ใยหิน (Asbestos fibers) ในงานอุตสาหกรรม เช่น ตู้ต่อเรือ หรือฉนวนกันความร้อน

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 29 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

30. ตอบ B ข้อ 30 • The most likely diagnosis

MOCK-030 • Lec M02

อาการเข้าได้กับ CRAB criteria ของ Multiple myeloma: Calcium สูง, Renal insufficiency, Anemia, Bone lytic lesions ร่วมกับมี Globulin gap สูง (Total protein - Albumin > 4)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 30 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

31. ตอบ ข้อ 31 • The primary mechanism of pleural effusion accumulation in this patient

MOCK-031 • Lec M02

กลไกหลักของการเกิดน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็ง (Malignant pleural effusion)

คือการที่เซลล์มะเร็งอุดตันหรือรุกรานทางเดินท่อน้ำเหลืองของเยื่อหุ้มปอด (Pleural lymphatic obstruction) ทำให้การระบายน้ำกลับเสียไป

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 31 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

32. ตอบ E ข้อ 32 • The diagnostic test of choice

MOCK-032 • Lec M02

Virchow's node (ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้ายโต) ร่วมกับอาการอึดเร็ว น้ำหนักลด สงสัยมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric adenocarcinoma) การตรวจวินิจฉัยหลักคือ Upper GI endoscopy พร้อมสุ่มตัดชิ้นเนื้อ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 32 • Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63

33. ข้อ 33 · Which of the following modalities is recommended by international clinical guidelines

MOCK-033 ·
Lec M02

แนวทางคัดกรองมะเร็งปอดในผู้สูบบุหรี่จัดกลุ่มเสี่ยงสูง แนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดปริมาณรังสีต่ำรายปี (Annual Low-Dose CT / LDCT)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 33 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

34. ตอบ C ข้อ 34 · The most likely diagnosis MOCK-034 · Lec M02

ก้อนปึกมดลูกชนิด solid/cystic ร่วมกับค่าสารบ่งชี้มะเร็ง CA-125 สูงในหญิงวัยกลางคน เข้าได้มากที่สุดกับ Epithelial ovarian carcinoma (มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อชู)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 34 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

35. ตอบ C ข้อ 35 · Which malignancy is most strongly suggested MOCK-035 · Lec M02

Courvoisier sign (คลำพบถุงน้ำดีโตแบบไม่กดเจ็บ ร่วมกับตาเหลืองตัวเหลืองแบบไม่ปวด)

เป็นลักษณะเฉพาะของการอุดตันทางเดินน้ำดีจากมะเร็งส่วนหัวตับอ่อน (Pancreatic head adenocarcinoma)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 35 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

36. ตอบ B ข้อ 36 · The diagnosis MOCK-036 · Lec M02

อาการคลาสสิก triad (ปัสสาวะเป็นเลือด, ปวดเอว, คลำได้ก้อน) ร่วมกับภาวะความเข้มข้นเลือดสูงจาก EPO หลังผิดปกติ (Paraneoplastic syndrome) เข้าได้กับ Renal cell carcinoma (RCC)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 36 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63

37. ตอบ D ข้อ 37 · Which thyroid malignancy is indicated MOCK-037 · Lec M02

ลักษณะทางพยาธิวิทยา Orphan Annie eye nuclei, nuclear grooves และ psammoma bodies เป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญของ

Papillary thyroid carcinoma

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 37 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

38. ตอบ A ข้อ 38 · Which pharmacologic class reduces skeletal-related events

MOCK-038 · Lec M02

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางกระดูก (Skeletal-related events เช่น กระดูกหัก ทับเส้นประสาท)

ในมะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายมากระดูก ยาที่แนะนำคือ Bisphosphonates (Zoledronic acid) หรือ Denosumab

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 38 · Oncology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.2** เนื้องอกและมะเร็ง (ทั้งหมด) — 2.3.2 Neoplasm หน้า 63
-

39. ตอบ E ข้อ 39 · Which laboratory serum profile is diagnostic of iron deficiency anemia

MOCK-039 · Lec M03

โลหิตจางจากการขาดเหล็ก (Iron deficiency anemia) มีผลแล็บเฉพาะคือ Serum Ferritin ต่ำ (สะท้อนเหล็กสะสมต่ำ) และ TIBC สูงขึ้น

(Total Iron Binding Capacity)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 39 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63
-

40. ตอบ C ข้อ 40 · Which is the initial first-line treatment MOCK-040 · Lec M03

ภาวะ Immune Thrombocytopenia (ITP) ที่มีเกล็ดเลือดต่ำและไม่มีบวมโตของตับมิล การรักษารักษาอันดับแรกคือให้ Oral Corticosteroids (Prednisolone) เพื่อลดการทำลายเกล็ดเลือด

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 40 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

41. ตอบ A ข้อ 41 · Which mechanism accounts for these findings MOCK-041 · Lec M03

การขาดวิตามินบี 12 ในมังสวิรัตเคร่งครัด รบกวนการสังเคราะห์ DNA ในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง (Impaired DNA synthesis)

ทำให้เกิด Megaloblastic anemia ร่วมกับอาการทางระบบประสาท

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 41 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

42. ตอบ ข้อ 42 · Which testing set confirms von Willebrand Disease (vWD) MOCK-042 · Lec M03

การยืนยันวินิจฉัย von Willebrand Disease (vWD) ต้องตรวจ vWF antigen (ปริมาณ vWF), Ristocetin cofactor activity (การทำงานของ vWF) และ Factor VIII activity assay

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 42 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

43. ตอบ E ข้อ 43 · Which characterizes this defect MOCK-043 · Lec M03

ภาวะเลือดออกในข้อ (Hemarthrosis) ร่วมกับ aPTT ยาวที่แก้ไขด้วย mixing study ในผู้ชาย เข้าได้กับ Hemophilia (A หรือ B) ซึ่งเป็นความผิดปกติของ Secondary hemostasis (ขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 43 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

44. ตอบ E ข้อ 44 · Which is the most likely diagnosis MOCK-044 · Lec M03

เม็ดเลือดขาวสูงมาก พบตัวอ่อนเม็ดเลือดขาวครบทุกระยะ ม้ามโตมาก และตรวจพบ Philadelphia chromosome t(9;22) BCR-ABL1

เป็นการวินิจฉัยเฉพาะของ Chronic Myeloid Leukemia (CML)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 44 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

45. ตอบ D ข้อ 45 · Which is the diagnosis MOCK-045 · Lec M03

เกล็ดเลือดสูงเรื้อรังเกิน 450,000 (ในข้อนี้ 1.25 ล้าน) ร่วมกับการตรวจพบยีนกลายพันธุ์ JAK2 V617F โดยไม่มีภาวะไขกระดูกฝ่อหรือมะเร็งอื่น

เข้าเกณฑ์วินิจฉัย Essential Thrombocythemia (ET)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 45 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

46. ตอบ E ข้อ 46 · What is the immediate step MOCK-046 · Lec M03

ภาวะ Acute hemolytic transfusion reaction จากการให้เลือดผิดหมู่สิ่งที่ต้องทำทันทีเป็นอันดับแรกคือ หยุดการให้เลือดทันที (Stop

transfusion) และเปิดสารน้ำ Normal Saline เพื่อคงปริมาตรเลือดและปกป้องไต

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 46 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

47. ตอบ A ข้อ 47 · Mechanism of this reaction MOCK-047 · Lec M03

ภาวะ Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction (FNHTR)

มีสาเหตุเกิดจากแอนติบอดีของผู้รับปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวของผู้บริจาค (Donor WBCs) หรือสาร Cytokines ที่ค้างในถุงเลือดระหว่างเก็บรักษา

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 47 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

48. ตอบ C ข้อ 48 · Which is the diagnosis MOCK-048 · Lec M03

หอบเหนื่อยหลังได้เลือดปริมาณมาก/รวดเร็ว ร่วมกับความดันโลหิตสูง เส้นเลือดคอโป่ง (JVD) และหัวใจโต เข้าได้กับ Transfusion-Associated Circulatory Overload (TACO) (ต่างจาก TRALI ที่มักมีความดันต่ำและไม่พบหัวใจโต)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 48 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

49. ตอบ C ข้อ 49 • What explains this coagulopathy MOCK-049 • Lec M03

การได้รับ packed red cells ปริมาณมากเกินไป 10 ยูนิตโดยไม่ได้เติม FFP หรือเกล็ดเลือด

ทำให้เกิดภาวะเจือจางของเกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Dilutional coagulopathy and thrombocytopenia)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 49 • Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

50. ตอบ E ข้อ 50 • Which enzyme deficiency MOCK-050 • Lec M03

การเกิดเม็ดเลือดแดงแตกหลังได้รับยาต้านมาลาเรีย (Primaquine) ร่วมกับพบ Heinz bodies และ Bite cells

เป็นลักษณะคลาสสิกของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 50 • Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

51. ตอบ B ข้อ 51 • Primary diagnosis MOCK-051 • Lec M03

อาการคันหลังอาบน้ำอุ่น (Aquagenic pruritus) ร่วมกับความเข้มข้นเลือดสูงทุกสาย (Panmyelosis: Red cells, WBC, Platelets)

และระดับ EPO ถูกกด ตรวจพบม้ามโต เป็นลักษณะของ Polycythemia Vera (PV)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 51 • Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

52. ตอบ C ข้อ 52 • Long-term management MOCK-052 • Lec M03

การวินิจฉัย Antiphospholipid Syndrome (APS) ที่มีประวัติลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (DVT)

การรักษามาตรฐานในระยะยาวเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันซ้ำคือ การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทางปากระยะยาว (Long-term oral anticoagulation)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 52 • Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

53. ตอบ B ข้อ 53 · Which agent rapidly corrects uremic bleeding prior to procedure

MOCK-053 · Lec M03

ภาวะเลือดออกจากเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติใน uremia (Uremic platelet dysfunction) การแก้ไขอย่างรวดเร็วก่อนทำหัตถการคือการให้

Desmopressin (dDAVP) หรือ Cryoprecipitate เพื่อเพิ่มการหลั่ง vWF

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 53 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

54. ตอบ B ข้อ 54 · Main mechanism responsible MOCK-054 · Lec M03

การตัดกระเพาะอาหาร (Gastrectomy) ทำให้สูญเสียเซลล์ Parietal ที่สร้าง Intrinsic Factor (IF) ส่งผลให้ไม่สามารถดูดซึมวิตามิน B12

ที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย (Ileum) ได้ เกิดโลหิตจางจากขาดวิตามิน B12

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 54 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

55. ตอบ D ข้อ 55 · Diagnosis MOCK-055 · Lec M03

เม็ดเลือดแดงเล็กมาก (Microcytosis) แต่จำนวนเม็ดเลือดแดงสูง (High RBC count) ร่วมกับผล Hb electrophoresis พบ HbA2 สูงขึ้น (> 3.5%) เป็นลักษณะเฉพาะของ Beta-thalassemia trait (minor)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 55 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

56. ตอบ E ข้อ 56 · Diagnosis MOCK-056 · Lec M03

ภาวะเม็ดเลือดต่ำทุกสาย (Pancytopenia) ร่วมกับผลเจาะไขกระดูกพบ Hypocellularity เติ่นชัด (> 90% fat replacement) โดยไม่มีเซลล์มะเร็ง เป็นลักษณะเฉพาะของ Aplastic Anemia

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 56 · Hematology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.3** โรคเลือดและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (ทั้งหมด) — 2.3.3 Diseases of blood and disorders involving the immune mechanism หน้า 63

57. ตอบ B ข้อ 57 • Diagnosis MOCK-057 • Lec M04

กล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาอ่อนแรง ร่วมกับผื่น Heliotrope rash ที่เปลือกตา และ Gottron's papules ที่ข้อชี้นิ้ว เป็นลักษณะคลาสสิกของ

Dermatomyositis

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 57 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

58. ตอบ C ข้อ 58 • Diagnosis MOCK-058 • Lec M04

ก้อนอักเสบใต้ผิวหนังสีแดงกดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Anterior shins) ร่วมกับผลพยาธิวิทยา Septal panniculitis คือภาวะ Erythema

nodosum (พบบ่อยสัมพันธ์กับการใช้ยา OCP หรือการติดเชื้อ)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 58 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

59. ตอบ B ข้อ 59 • Diagnosis MOCK-059 • Lec M04

ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารระคายเคืองโดยตรง (Irritant contact dermatitis) เกิดจากการใช้น้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ทำลายชั้นเกราะป้องกันผิวหนังโดยไม่ได้ผ่านกลไกภูมิแพ้

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 59 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

60. ตอบ E ข้อ 60 • Diagnosis MOCK-060 • Lec M04

ตุ่มน้ำใสคันมากคล้ายเม็ดสาคู (Tapioca-like vesicles) บริเวณข้อมือและฝ่ามือ กำมือเมื่ออากาศร้อนหรือเครียด เป็นลักษณะของ

Dyshidrotic eczema (Pompholyx)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 60 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

61. ตอบ D ข้อ 61 • Primary pathogen MOCK-061 • Lec M04

การติดเชื้อชั้นผิวหนังด้านบวมที่ขอบชัดเจน (Sharply demarcated) ร่วมกับ Milian's ear sign คือภาวะ Erysipelas ซึ่งมีเชื้อสาเหตุหลักมาจาก Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 61 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68

62. ตอบ B ข้อ 62 • Most appropriate antiviral therapy MOCK-062 • Lec M04

งูสวัด (Herpes zoster) ตามแนวเส้นประสาท (Dermatome) การรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลักคือ Oral Acyclovir 800 mg วันละ 5 ครั้ง (หรือ

Valacyclovir) เป็นเวลา 7 วัน

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 62 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

63. ตอบ D ข้อ 63 • Recommended first-line topical treatment MOCK-063 • Lec M04

ลักษณะ 6 Ps (Pruritic, Purple, Polygonal, Planar, Papules, Plaques) ร่วมกับ Wickham's striae เป็นลักษณะเฉพาะของ Lichen planus การรักษาอันดับแรกคือ Topical high-potency corticosteroid

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 63 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

64. ตอบ A ข้อ 64 • Most effective oral treatment regimen MOCK-064 • Lec M04

เชื้อราที่เล็บเท้า (Onychomycosis) การรักษาด้วยยารับประทานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ Oral Terbinafine 250 mg วันละครั้ง เป็นเวลา

12 สัปดาห์

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 64 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

65. ตอบ A ข้อ 65 • Responsible toxin MOCK-065 • Lec M04

Bullous impetigo ในเด็ก เกิดจากการที่เชื้อ Staphylococcus aureus สร้าง Exfoliative toxin (ETA/ETB)

ไปทำลายสารยึดเซลล์ผิวหนัง desmoglein-1 ทำให้เกิดตุ่มน้ำพองสะเก็ดสีน้ำตาล

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 65 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

66. ตอบ C ข้อ 66 • Diagnosis MOCK-066 • Lec M04

ผู้ป่วยรุนแรงที่มีการหลุดลอกของผิวหนังและเยื่อ 10-30% BSA (ในข้อนี้ 25%) ร่วมกับ Nikolsky sign ผลบวก เป็นภาวะ SJS/TEN overlap (หาก <10% เป็น SJS, >30% เป็น TEN)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 66 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68

67. ตอบ A ข้อ 67 • Underlying immunopathogenesis MOCK-067 • Lec M04

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เกิดจากพยาธิสภาพภูมิคุ้มกันผ่าน T-cell (T-cell mediated autoimmune) กระตุ้นการเพิ่มจำนวนและแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง keratinocyte อย่างรวดเร็วผิดปกติ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 67 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

68. ตอบ C ข้อ 68 • Diagnosis MOCK-068 • Lec M04

ตุ่มน้ำพองชนิดตึง แดงยาก (Tense bullae) ในผู้สูงอายุ ไม่พบแผลในปาก ร่วมกับผล DIF พบ linear IgG/C3 ที่ชั้น basement membrane (ต่อต้าน BP180/BP230) คือภาวะ Bullous pemphigoid

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 68 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

69. ตอบ B ข้อ 69 • Pathogenic autoantibodies MOCK-069 • Lec M04

ตุ่มน้ำชนิดแตกง่าย (Flaccid blisters) มีแผลในปาก เด่นชัด ร่วมกับ Nikolsky sign ผลบวก และ DIF พบ net-like pattern เกิดจากแอนติบอดี Anti-desmoglein-3 (และ 1) ในโรค Pemphigus vulgaris

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 69 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

70. ตอบ A ข้อ 70 • Treatment of choice MOCK-070 • Lec M04

อาการคันมากตอนกลางคืน พบตุ่มและรอยขูด (Burrows) ตามง่ามนิ้วมือ เข้าได้กับโรคหิด (Scabies) ยารักษามาตรฐานอันดับแรก คือ 5%

Permethrin cream ทาหัวตัวตั้งแต่คอลงมาทั้งไว้ข้ามคืน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 70 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

71. ตอบ D ข้อ 71 • Acnes MOCK-071 • Lec M04

สิวอักเสบและสิวลุดตัน (Acne vulgaris) การรักษาลำดับแรกผสมผสานยาทา Retinoid (ลด hyperkeratinization) ร่วมกับ Benzoyl

Peroxide (ฆ่าเชื้อ C. acnes และลดดีอี๋ยา)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 71 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68

72. ตอบ A ข้อ 72 • Causative organism MOCK-072 • Lec M04

เกลื้อน (Tinea versicolor) มีลักษณะส่องไฟ Wood's lamp พบสีเหลืองทอง และ KOH พบสายราสั้นพร้อมสปอร์ (Spaghetti and meatballs) เกิดจากเชื้อรา *Malassezia furfur* (globosa)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 72 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

73. ตอบ C ข้อ 73 • Diagnosis MOCK-073 • Lec M04

ผมร่วงเป็นวงขอบชัดเจน ผิวหนังเรียบไม่มีสะเก็ด ร่วมกับพบเส้นผมลักษณะ Exclamation mark hair บริเวณขอบวง คือโรคผมร่วงเป็นวงจากภูมิคุ้มกัน (Alopecia areata)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 73 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

74. ตอบ B ข้อ 74 • Most effective topical therapy MOCK-074 • Lec M04

ผื่นผิวหนังอักเสบเซบเดิร์ม (Seborrheic dermatitis) มีผื่นสะเก็ดมันสีเหลืองบริเวณที่มีต่อมไขมันมาก การรักษาหลักคือการใช้ยาทาต้านเชื้อรา

เช่น Ketoconazole 2% shampoo/cream

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 74 • Dermatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.12** โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (ทั้งหมด) — 2.3.12 Disorders of skin and subcutaneous tissue หน้า 68
-

75. ตอบ D ข้อ 75 • Disease-modifying agent initiated in all SLE patients MOCK-075 • Lec M05

ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยโรค SLE ยา Hydroxychloroquine (HCQ) มีข้อบ่งชี้ให้ในผู้ป่วย SLE ทุกรายที่ไม่มีข้อห้าม เพื่อลดการกำเริบของโรค

ลดอัตราการเสียชีวิต และป้องกันความเสียหายของอวัยวะ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 75 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69
-

76. ตอบ C ข้อ 76 • Diagnosis MOCK-076 • Lec M05

อาการคาบเกี่ยวของโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 3 โรค (SLE + Scleroderma + Polymyositis) ร่วมกับมีผลเลือดบวกต่อ Anti-U1 RNP จำเพาะ เป็นการวินิจฉัย Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 76 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

77. ตอบ D ข้อ 77 • Diagnosis MOCK-077 • Lec M05

ปวดข้อเข้าสัมพันธ์กับการใช้งาน ผิดตั้งช่วงเช้าสั้นๆ (<30 นาที) ตรวจพบ crepitus และ X-ray พบ osteophytes ร่วมกับ joint space

narrowing เข้าได้กับ Osteoarthritis (ข้อเข่าเสื่อม)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 77 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

78. ตอบ D ข้อ 78 • Acute management of choice MOCK-078 • Lec M05

ข้อนิ้วหัวแม่มืออักเสบเฉียบพลัน (Podagra) ร่วมกับผลเจาะข้อพบผลึกยูเรตัมหักเหแสงเป็นลบ (Strongly negatively birefringent)

คือโรคเกาต์เฉียบพลัน การรักษาคือ Oral NSAIDs หรือ Colchicine (ห้ามเริ่ม Allopurinol โดสสูงทันที)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 78 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

79. ตอบ E ข้อ 79 • Responsible crystal type MOCK-079 • Lec M05

ผลึกยูเรตัมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หักเหแสงเป็นบวกอ่อนๆ (Weakly positively birefringent) ร่วมกับ X-ray พบหินปูนในกระดูกอ่อน (Chondrocalcinosis) เกิดจาก Calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD / Pseudogout)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 79 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

80. ตอบ E ข้อ 80 • Diagnosis MOCK-080 • Lec M05

อาการเข้าตาม Jones criteria: Migratory polyarthritits ร่วมกับ Carditis (เสียงฟู่ลิ้นหัวใจ) หลังการติดเชื้อคออักเสบจาก Streptococcal กลุ่ม A วินิจฉัยเป็น Acute Rheumatic Fever (ใช้รูมาติกเฉียบพลัน)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 80 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

81. ตอบ B ข้อ 81 • First-line pharmacotherapy MOCK-081 • Lec M05

โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) การรักษาทางยาอันดับแรก (First-line treatment) คือการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ขนาดเต็มที่

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 81 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

82. ตอบ B ข้อ 82 • Anchor first-line DMARD MOCK-082 • Lec M05

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) ที่ยืนยันผลด้วย Anti-CCP ยาในกลุ่ม DMARDs ที่เป็นหลักอันดับแรก (Anchor first-line DMARD) คือ Methotrexate (MTX)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 82 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

83. ตอบ D ข้อ 83 • Specific clinical entity MOCK-083 • Lec M05

อาการกลุ่ม CREST syndrome ร่วมกับตรวจพบ Anti-centromere antibodies ให้ผลบวก เป็นลักษณะเฉพาะของ Limited Systemic Sclerosis

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 83 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

84. ตอบ C ข้อ 84 • Diagnosis MOCK-084 • Lec M05

อาการตาแห้ง ปากแห้ง (Sicca syndrome) ร่วมกับ Schirmer test ให้ผลบวก และตรวจพบแอนติบอดี Anti-SSA/Anti-SSB เป็นลักษณะของการวินิจฉัยโรค Sjögren Syndrome

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 84 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

85. ตอบ E ข้อ 85 • Diagnosis MOCK-085 • Lec M05

พยาธิสภาพของทางเดินหายใจส่วนบน (จมูกอักเสบ) + ทางเดินหายใจส่วนล่าง (ไอบronไอบี) + ไตอักเสบ ร่วมกับ c-ANCA (PR3) ผลบวก

เป็นลักษณะเฉพาะของ Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener's)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 85 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

86. ตอบ C ข้อ 86 • Diagnosis MOCK-086 • Lec M05

กลุ่มอาการ Triad (ข้ออักเสบ, เยื่อตาอักเสบ, ท่อปัสสาวะอักเสบ) เกิดตามหลังการติดเชื้อทางเดินอาหาร (Campylobacter) คือโรค Reactive arthritis (Reiter's syndrome)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 86 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

87. ตอบ A ข้อ 87 • Diagnosis MOCK-087 • Lec M05

อาการตีบปวดบริเวณก้นคอ หัวไหล่ และสะโพกในผู้สูงอายุ ESR สูง โดยไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง และตอบสนองดีเยี่ยมต่อยาสเตียรอยด์ขนาดต่ำ คือโรค

Polymyalgia Rheumatica (PMR)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 87 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

88. ตอบ E ข้อ 88 • Most urgent step to prevent permanent vision loss MOCK-088 • Lec M05

Giant Cell (Temporal) Arteritis สงสัยจากอาการปวดขาบ Jaw claudication และ ESR สูงมาก

สิ่งที่ต้องทำทันทีโดยไม่ต้องรอผลตัดชิ้นเนื้อคือ การให้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูง (High-dose corticosteroids) ทันทีเพื่อป้องกันตาบอดถาวร

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 88 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

89. ตอบ D ข้อ 89 • Diagnosis MOCK-089 • Lec M05

อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกายเรื้อรัง อ่อนเพลีย พบจุดกดเจ็บเฉพาะ (Tender points) โดยที่การตรวจแล็บและการเอกซเรย์ทั้งหมดเป็นปกติ เข้าได้กับ

Fibromyalgia

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 89 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

90. ตอบ D ข้อ 90 • Immediate plan MOCK-090 • Lec M05

ข้อเข้าอักเสบเป็นหนองติดเชื้อแบคทีเรีย (Septic arthritis) สิ่งที่ต้องทำทันทีคือ การเจาะ/ล้างระบายหนองออกจากข้อ (Joint drainage)

ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ (IV antibiotics)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 90 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

91. ตอบ C ข้อ 91 • Diagnosis MOCK-091 • Lec M05

แผลร้อนในในปากและอวัยวะเพศเป็นๆ หายๆ ร่วมกับม่านตาอักเสบ (Uveitis) และ Pathergy test ผลบวก เป็นลักษณะเฉพาะของ Behçet Disease

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 91 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

92. ข้อ 92 • Prior to initiating urate-lowering therapy, which co-prescription is necessary to prevent

MOCK-092 • Lec M05

การเริ่มยาลดกรดยูริก (Allopurinol) อาจกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์กำเริบเฉียบพลันได้จึงจำเป็นต้องให้ยาต้านการอักเสบขนาดต่ำร่วมด้วยเสมอ เช่น

Low-dose Colchicine หรือ NSAID เป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนแรก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 92 • Rheumatology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.13** โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ทั้งหมด) — 2.3.13 Disorders of the musculoskeletal system and connective tissue หน้า 69

93. ตอบ D ข้อ 93 · Most appropriate acute intervention MOCK-093 · Lec M06

ผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) ที่มาภายในระยะเวลาทอง (Window period < 4.5 ชั่วโมง) และ CT สแกนไม่พบเลือดออก ต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด IV rtPA (Alteplase) ทันที

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 93 · Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

94. ตอบ D ข้อ 94 · Anatomical lesion located MOCK-094 · Lec M06

ภาวะเสียการสื่อความแบบไม่ราบรื่น (Non-fluent / Expressive aphasia) โดยที่ความเข้าใจภาษายังดีอยู่ เกิดจากรอยโรคที่ Left inferior frontal gyrus (Broca's area)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 94 · Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

95. ตอบ ข้อ 95 · Which structure is directly compressed against tentorium cerebelli MOCK-095 · Lec M06

Uncal herniation ทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 (CN III / Oculomotor nerve) ด้านเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นใยประสาทพาราซิมพาเทติก ทำให้รูม่านตาขยายโตและไม่ตอบสนองต่อแสง

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 95 · Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

96. ตอบ ข้อ 96 · Neuroanatomical localization best explaining altered sensorium MOCK-096 · Lec M06

อาการ Flapping tremor (Asterixis) ร่วมกับซึมสับสนแบบไม่มีรอยโรคเฉพาะส่วน เกิดจากภาวะสมองทำงานผิดปกติทั่วๆ ไปจากสาเหตุเมแทบอลิก (Diffuse metabolic encephalopathy)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 96 · Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

97. ตอบ D ข้อ 97 · Drug of choice MOCK-097 · Lec M06

ภาวะ Delirium Tremens (DTs) จากการถอนสุราเฉียบพลัน ยาที่เป็นตัวเลือกแรกและสำคัญที่สุดในการรักษาคือยากลุ่ม Benzodiazepines (เช่น Lorazepam หรือ Diazepam)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 97 · Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65

98. ตอบ D ข้อ 98 • Diagnosis MOCK-098 • Lec M06

ปวดศีรษะลักษณะตื้อตื้อเหมือนมีอะไรรัดรอบศีรษะ เป็นสองข้าง ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือกลัวแสง เป็นลักษณะของ Tension-type headache

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 98 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

99. ข้อ 99 • Single most critical historical element required to determine eligibility for IV thrombolytic MOCK-099 • Lec M06

ประวัติที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจให้ยาละลายลิ่มเลือด (rtPA) คือ เวลาที่เริ่มมีอาการแน่นอน (Exact time of symptom onset / Last known well) เพื่อประเมินว่ายังอยู่ในกรอบเวลา 4.5 ชั่วโมงหรือไม่

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 99 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

100. ตอบ E ข้อ 100 • Diagnosis MOCK-100 • Lec M06

อาการปวดศีรษะรุนแรงที่สุดในชีวิตแบบทันทีทันใด (Thunderclap headache / Worst headache of life) ร่วมกับพบเงาสีขาวสว่างใน basal cisterns เป็นลักษณะของ Subarachnoid hemorrhage (SAH)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 100 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

101. ตอบ B ข้อ 101 • Diagnosis MOCK-101 • Lec M06

แขนขาอ่อนแรงแบบขึ้นตามลำดับ (Ascending weakness), Reflex ดับหมด ร่วมกับ CSF พบโปรตีนสูงแต่เซลล์ปกติ (Albuminocytologic dissociation) คือ Guillain-Barré Syndrome (GBS)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 101 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

102. ตอบ C ข้อ 102 • Diagnosis MOCK-102 • Lec M06

กล้ามเนื้อตาคด หนังตาคด อ่อนแรงง่ายเมื่อยใช้งาน ล้าลงตอนเย็น (Fatigability) ร่วมกับตรวจพบ Anti-AChR antibodies คือโรค Myasthenia Gravis (MG)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 102 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65

103. ตอบ B ข้อ 103 • Diagnosis MOCK-103 • Lec M06

รอยโรคในระบบประสาทหลายตำแหน่งและหลายช่วงเวลา (Dissemination in time & space) ร่วมกับ oligoclonal bands ใน CSF

และรอยโรค Dawson's fingers บน MRI คือ Multiple Sclerosis (MS)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 103 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.6 โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

104. ตอบ ข้อ 104 • Which neurotransmitter deficiency in substantia nigra A pars compacta MOCK-104 • Lec M06

โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) มีอาการสั่นขณะพัก เคลื่อนไหวช้า และเกร็ง เกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองที่สร้างสารสื่อประสาท

Dopamine ในบริเวณ Substantia nigra pars compacta

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 104 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.6 โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

105. ตอบ E ข้อ 105 • Action required prior to performing lumbar puncture MOCK-105 • Lec M06

ผู้ป่วยสงสัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสัญญาณเตือนของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Papilledema, สับสน)

ต้องส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) ก่อนเจาะหลังเสมอเพื่อป้องกันสมองเคลื่อนโดนกดทับ (Herniation)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 105 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.6 โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

106. ตอบ B ข้อ 106 • Diagnosis MOCK-106 • Lec M06

รอยโรคก้อนสีชาขาวสด (Hyperdense hematoma) ในเนื้อสมองบริเวณ Basal ganglia จากภาวะความดันโลหิตสูง คือ Intracerebral

hemorrhage (ICH)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 106 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.6 โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65

107. ตอบ B ข้อ 107 • Effective acute abortive treatment MOCK-107 • Lec M06

โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ (Cluster headache) การรักษาเฉียบพลันที่ได้ผลดีที่สุดและเป็นมาตรฐานคือ การสูดดมออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

อัตราไหลสูง (100% High-flow oxygen) ทางหน้ากาก non-rebreather

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 107 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

108. ตอบ C ข้อ 108 • Pharmacologic agent indicated for acute abortive therapy MOCK-108 • Lec M06

ไมเกรนชนิดมีออรา (Migraine with aura) การรักษาจำเพาะในระยะเฉียบพลันสำหรับอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงคือ ยากลุ่ม Triptans

(เช่น Sumatriptan)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 108 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

109. ตอบ C ข้อ 109 • Diagnosis MOCK-109 • Lec M06

อาการคลาสสิก Triad (เดินเซ, ปัสสาวะราด, สมอเงิ้ม) ร่วมกับโพรงสมองโต และอาการเดินดีขึ้นหลังเจาะระบายน้ำไขสันหลัง (Tap test)

เป็นภาวะ Normal Pressure Hydrocephalus (NPH)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 109 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65
-

110. ตอบ D ข้อ 110 • First-line intravenous medication MOCK-110 • Lec M06

ภาวะชักต่อเนื่อง (Status epilepticus > 5 นาที) ยาฉีดอันดับแรกในการหยุดชักทันทีคือยากลุ่ม IV Benzodiazepines (เช่น IV Lorazepam หรือ IV Diazepam)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 110 • Neurology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.6** โรคระบบประสาท (ทั้งหมด) — 2.3.6 Disorders of the nervous system หน้า 65

111. ตอบ A ข้อ 111 • Diagnosis MOCK-111 • Lec M07

เสียงหัวใจ S1 ดัง, มี Opening snap ตามหลัง S2 และเสียงหัวใจฟู mid-diastolic rumbling ที่ยอดหัวใจ (Apex) เป็นลักษณะคลาสสิกของ Mitral stenosis (ลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 111 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

112. ตอบ B ข้อ 112 • Hemodynamic mechanism causing shock MOCK-112 • Lec M07

กลุ่มอาการ Beck's triad (ความดันต่ำ, เส้นเลือดคอโป่ง, เสียงหัวใจเบา) ร่วมกับ Pulsus paradoxus เกิดจากภาวะ Pericardial tamponade ซึ่งขัดขวางการคลายตัวเดิมเลือดของหัวใจ จัดเป็น Obstructive shock

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 112 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

113. ตอบ C ข้อ 113 • AV block type MOCK-113 • Lec M07

ลักษณะ EKG ที่ PR interval ค่อยๆ ยาวขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมี P wave ที่ไม่ถูกส่งผ่านเกิดเป็น dropped QRS 1 ตัว แล้วเริ่มรอบใหม่คือ

Second-degree AV block, Mobitz Type I (Wenckebach)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 113 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

114. ตอบ B ข้อ 114 • Most appropriate long-term antithrombotic management

MOCK-114 • Lec M07

ผู้ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Non-valvular AF) ที่มี CHA2DS2-VASc score ≥ 2 (ข้อนี้ได้ 5 คะแนน)

มีข้อบ่งชี้มาตรฐานให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดทางปากระยะยาว (Oral Anticoagulant เช่น DOACs หรือ Warfarin) เพื่อป้องกันอัมพาต

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 114 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67

115. ตอบ D ข้อ 115 • Primary pathophysiological mechanism MOCK-115 • Lec M07

อาการเจ็บหน้าอกแบบ Stable angina (เจ็บเมื่อออกกำลังกาย พักแล้วหายใน 5 นาที) เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบจากคราบไขมันเกาะดั้งเดิม (Fixed

atherosclerotic stenosis) ทำให้เกิดความไม่สมดุลของความต้องการและสารอาหารเลี้ยงหัวใจขณะออกกำลังกาย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 115 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

116. ตอบ A ข้อ 116 • Diagnosis MOCK-116 • Lec M07

เจ็บหน้าอกแปล๊บๆ บรรเทาลงเมื่อนอนตัวไปข้างหน้า ร่วมกับ EKG พบ diffuse ST-elevation และ PR depression หลายลีด เป็นลักษณะคลาสสิกของ Acute pericarditis (ถุงคัมหัวใจอักเสบเฉียบพลัน)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 116 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

117. ข้อ 117 • Which drug combination represents essential disease-modifying therapy to reduce mortality MOCK-117 • Lec M07

การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิด HFrEF ตามแนวทางล่าสุด 4 เสาหลัก (Fantastic Four) ที่ลดอัตราการเสียชีวิต ได้แก่ ARNI/ACEi +

Evidence-based Beta-blocker + MRA (Spironolactone) + SGLT2 inhibitor

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 117 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

118. ตอบ E ข้อ 118 • Additional evaluation performed immediately MOCK-118 • Lec M07

ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดผนังล่าง (Inferior STEMI) ร่วมกับความดันต่ำและ JVD สูง สงสัยภาวะ Right Ventricular Infarction

ต้องทำ Right-sided ECG (V3R, V4R) ทันทีเพื่อยืนยัน (และห้ามให้ยาขยายหลอดเลือด/ยาขับปัสสาวะ)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 118 • Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67

119. ตอบ A ข้อ 119 · Most appropriate next clinical step MOCK-119 · Lec M07

ผู้ป่วยสงสัยภาวะเจ็บหน้าอกขาดเลือดเฉียบพลันที่ผลตรวจ EKG และ Troponin เริ่มต้นเป็นปกติต้องได้รับการส่งตรวจ serial Troponin

ซ้ำและติดตาม EKG ซ้ำในอีก 1-3 ชั่วโมงต่อมาเสมอ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 119 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

120. ตอบ D ข้อ 120 · Immediate treatment of choice MOCK-120 · Lec M07

หัวใจเต้นเร็วเวทริเคิลชนิดกว้าง (Wide-complex tachycardia / VT) ที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ (Unstable: ความดันตก 80/45) การรักษาฉุกเฉินอันดับแรกคือ Synchronized DC Cardioversion ทันที

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 120 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

121. ตอบ E ข้อ 121 · Management MOCK-121 · Lec M07

ภาวะ 1st-degree AV block (PR > 0.20s) ที่ไม่มีอาการและไม่มีรอยโรคอื่น ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาใดๆ แนะนำสังเกตอาการและให้คำมั่นแนะนำ (Observation and reassurance)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 121 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

122. ตอบ C ข้อ 122 · Diagnosis MOCK-122 · Lec M07

อาการคลาสสิก Triad (Syncope, Angina, Dyspnea) ร่วมกับเสียงพู่ crescendo-decrescendo systolic ที่ขอบขวาบนของกระดูกอก ร้าวไปหลอดเลือดคอ คือโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic stenosis)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 122 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

123. ตอบ A ข้อ 123 · Diagnosis MOCK-123 · Lec M07

เสียงพู่ systolic ที่ดังก้องขึ้นเมื่อลดเลือดเข้าหัวใจ (Valsalva / Standing) และเบาลงเมื่อ squatting ร่วมกับประวัติครอบครัวเสียชีวิตกะทันหันในวัยหนุ่มสาว คือ Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 123 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.9 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67

124. ตอบ E ข้อ 124 · First-line antihypertensive to slow renal disease progression

MOCK-124 · Lec M07

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังและมีโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ยาลดความดันโลหิตตัวเลือกแรกเพื่อชะลอความเสื่อมของไตคือยาในกลุ่ม ACE inhibitors หรือ ARBs

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 124 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

125. ตอบ B ข้อ 125 · Step prior to empiric antibiotics MOCK-125 · Lec M07

ผู้ป่วยสงสัยเยื่อหัวใจอักเสบติดเชื้อ (Infective endocarditis) สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนเริ่มยาปฏิชีวนะเสมอคือ การเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ (Blood cultures) 3 ชุด จากตำแหน่งหลอดเลือดต่างกัน

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 125 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

126. ตอบ C ข้อ 126 · Diagnostic imaging modality of choice MOCK-126 · Lec M07

ปวดเจ็บหน้าอกทะลุหลังแบบฉีกขาด (Tearing chest pain) ร่วมกับความดันสองแขนต่างกันเกิน 20 mmHg การส่งตรวจภาพรังสีเพื่อยืนยัน

Aortic dissection ที่ดีที่สุดคือ Contrast-enhanced CT Angiography

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 126 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

127. ตอบ A ข้อ 127 · Immediate initial medical therapy MOCK-127 · Lec M07

ภาวะปอดบวมน้ำเนียบพลันจากหัวใจล้มเหลว (Acute pulmonary edema) การรักษาตัวนคือ ให้ Oxygen, IV Loop Diuretics (Furosemide) เพื่อขับน้ำออก และ IV Nitroglycerin เพื่อลด preload/afterload

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 127 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67
-

128. ตอบ D ข้อ 128 · Diagnosis MOCK-128 · Lec M07

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Acute myocarditis) เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัส (เช่น Coxsackievirus B) ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจการบีบตัวลดลงทั่วๆ (Global hypokinesis) และเอนไซม์หัวใจสูง

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 128 · Cardiology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.9** โรคระบบไหลเวียนโลหิต (ทั้งหมด) — 2.3.9 Disorders of the circulatory system หน้า 67

129. ตอบ C ข้อ 129 · Fundamental pathophysiological mechanism MOCK-129 · Lec M08

โรคหืด (Asthma) มีพยาธิสรีรวิทยาหลักคือ การอักเสบเรื้อรังของหลอดลมร่วมกับภาวะหลอดลมไวเกินที่สามารถหดเกร็งและคลายตัวกลับคืนได้

(Reversible airway hyperresponsiveness)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 129 · Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

130. ตอบ E ข้อ 130 · Diagnosis MOCK-130 · Lec M08

อาการหอบหืดที่สัมพันธ์ชัดเจนกับการทำงาน (กำเริบวันทำงาน ดีขึ้นวันหยุด) ในอาชีพคนทำขนมปัง (สัมผัสแป้งสาลี) คือโรคหืดจากการทำงาน

(Occupational asthma)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 130 · Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

131. ตอบ ข้อ 131 · Which spirometric ratio confirms persistent airflow limitation in COPD MOCK-131 · Lec M08

เกณฑ์เป่าปอดในการยืนยันภาวะหลอดลมตีบอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) คือ สัดส่วน Post-bronchodilator FEV1/FVC < 0.70

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 131 · Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

132. ตอบ ข้อ 132 · Recommended outpatient empiric oral antibiotic regimen MOCK-132 · Lec M08

ผู้ป่วยปอดอักเสบติดเชื้อในชุมชน (CAP) ผู้ป่วยนอกที่มีโรคร่วม (เช่น เบาหวาน) แนะนำให้ยาปฏิชีวนะครอบคลุมเชื้อก่อโรคทั่วไปและ Atypical

pathogens ได้แก่ Amoxicillin-clavulanate ร่วมกับ Macrolide (หรือ Doxycycline)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 132 · Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67

133. ตอบ E ข้อ 133 • Immediate step MOCK-133 • Lec M08

ภาวะ Tension pneumothorax (ซีก, หลอดลมเอียง, เสียงปอดดับด้านเดียว) เป็นภาวะฉุกเฉินถึงชีวิต สิ่งที่ต้องทำทันทีโดยไม่ต้องรอถ่ายภาพ

X-ray คือ Needle decompression ทันที

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 133 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.10 โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

134. ตอบ D ข้อ 134 • Definitive diagnostic imaging modality MOCK-134 • Lec M08

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด (Pulmonary Embolism / PE) การตรวจทางรังสีที่เป็นมาตรฐานทองคำและตรวจยืนยันได้ดีที่สุดคือ CT

Pulmonary Angiography (CTPA)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 134 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.10 โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

135. ตอบ C ข้อ 135 • Correct blood gas interpretation MOCK-135 • Lec M08

ผล ABG พบ pH เป็นกรด (< 7.35) ร่วมกับ PaCO_2 สูง (> 45 mmHg) และ HCO_3^- ยังอยู่ในช่วงปกติ แปลผลเป็น Acute respiratory acidosis จากการกดการหายใจ (Hypoventilation)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 135 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.10 โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

136. ตอบ A ข้อ 136 • Primary mechanism MOCK-136 • Lec M08

ฝีในปอด (Lung abscess) ในผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง เกิดจากการสำลักสิ่งค้างในช่องปากที่มีเชื้อ Anaerobes (Aspiration of oral anaerobic secretions) เข้าสู่ปอดจนเกิดการเน่าเสียของเนื้อปอด

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 136 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.10 โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

137. ตอบ A ข้อ 137 • Diagnosis MOCK-137 • Lec M08

น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดสีขาวขุ่นคล้ายนม ร่วมกับมีระดับ Triglycerides สูงเกิน 110 mg/dL เป็นการวินิจฉัยภาวะ Chylothorax (ท่อน้ำเหลืองฉีกขาดคั่งในช่องปอด)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 137 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.10 โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67

138. ตอบ D ข้อ 138 • Classification according to Light's criteria MOCK-138 • Lec M08

ตามเกณฑ์ Light's criteria หากมีข้อใดข้อหนึ่งเข้าเกณฑ์ (Protein ratio > 0.5 หรือ LDH ratio > 0.6 หรือ Pleural LDH > 2/3 upper limit) จัดเป็น Exudative pleural effusion

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 138 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

139. ตอบ E ข้อ 139 • Indicated adjustment to inhaled therapy MOCK-139 • Lec M08

ผู้ป่วย COPD ที่มีกำเริบบ่อยและมี Blood eosinophils ≥ 150 -300 cells/ μ L มีข้อบ่งชี้ให้ปรับยาสูดเพิ่มยาสเตียรอยด์สูด (ICS) ร่วมเป็น

LABA + ICS หรือ Triple therapy (LAMA + LABA + ICS)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 139 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

140. ข้อ 140 • Which baseline clinical criteria represents definitive indication for Long-Term Home Oxyge

MOCK-140 •
Lec M08

ข้อบ่งชี้ในการให้ออกซิเจนที่บ้านระยะยาว (LTOT) ในผู้ป่วย COPD เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต คือ Resting PaO₂ ≤ 55 mmHg หรือ SpO₂ $\leq 88\%$

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 140 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

141. ตอบ C ข้อ 141 • Pneumoconiosis present MOCK-141 • Lec M08

ประวัติทำงานฉนวนกันความร้อน พบ Pleural plaques ร่วมกับพบ Ferruginous bodies (แท่งใยหินเคลือบธาตุเหล็ก) เป็นลักษณะเฉพาะของโรคปอดฝุ่นหินแร่ใยหิน (Asbestosis)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 141 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

142. ตอบ D ข้อ 142 • Complication MOCK-142 • Lec M08

ภาวะน้ำท่วมปอดหลังเจาะระบายน้ำอกรวดเร็วเกินไป (> 1.5 ลิตร) เรียกว่า Re-expansion pulmonary edema เกิดจากแรงดันในปอดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทำให้หลอดเลือดปอดรั่วซึม

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 142 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67

143. ตอบ E ข้อ 143 • **Appropriate initial management** MOCK-143 • Lec M08

ภาวะลมในช่องปอดเกิดขึ้นเองแบบปฐมภูมิขนาดเล็ก (< 15%) ในผู้ป่วยที่สัญญาณชีพคงที่การรักษาเริ่มต้นคือการสังเกตอาการและให้ออกซิเจนขนาดสูง (Observation + High-flow O2)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 143 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

144. ตอบ A ข้อ 144 • **Diagnosis** MOCK-144 • Lec M08

อาการนิ้วปม (Clubbing), ฟังปอดได้เสียง Velcro crackles และ HRCT พบ Honeycombing บริเวณฐานปอด เข้าได้ตามรูปแบบ UIP

pattern ของโรคพังผืดในปอดไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Pulmonary Fibrosis / IPF)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 144 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

145. ตอบ A ข้อ 145 • **Diagnosis** MOCK-145 • Lec M08

ตามเกณฑ์ Berlin definition: มีปัจจัยเสี่ยง (Trauma), ปอดบวมน้ำสองข้างโดยไม่ใช้จากหัวใจ (PCWP < 18) และ PaO2/FiO2 อยู่ระหว่าง 100-200 mmHg จัดเป็น Moderate ARDS

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 145 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67
-

146. ข้อ 146 • **Which non-pharmacological intervention has been proven to significantly reduce overall mor** MOCK-146 • Lec M08

การเลิกบุหรี่ (Smoking cessation) เป็นมาตรการไม่ใช้ยา duyเดียวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าชะลอการเสื่อมของสมรรถภาพปอดและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย COPD ได้อย่างมีนัยสำคัญ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 146 • Pulmonology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.10** โรคระบบการหายใจ (ทั้งหมด) — 2.3.10 Disorders of the respiratory system หน้า 67

147. ข้อ 147 · Physiological mechanism explaining action of
ตอบ E Spironolactone in cirrhotic ascites

MOCK-147 · Lec
M09

ภาวะท้องมานในโรคตับแข็งเกิดจาก Secondary hyperaldosteronism ยา Spironolactone ออกฤทธิ์ ยับยั้งตัวรับ Aldosterone ที่

distal tubule และ collecting duct จึงเป็นยาขับปัสสาวะตัวเลือกแรก

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 147 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

148. ข้อ 148 · Hemodynamic changes fundamental in pathogenesis of ascites
ตอบ D formation in portal hypertension

MOCK-148 ·
Lec M09

พยาธิกำเนิดหลักของการเกิดภาวะท้องมานในตับแข็ง คือแรงต้านหลอดเลือดในตับสูงขึ้น ร่วมกับการขยายตัวของหลอดเลือดในระบบช่องท้อง

(Splanchnic arterial vasodilation)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 148 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

149. ตอบ E ข้อ 149 · Diagnosis MOCK-149 · Lec M09

ตับอักเสบเฉียบพลันที่มีเอนไซม์ AST/ALT สูงเกิน 1,000 U/L และผลการตรวจน้ำเหลืองยืนยัน IgM anti-HAV ให้ผลบวก วินิจฉัยเป็น Acute Hepatitis A virus infection

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 149 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

150. ตอบ ข้อ 150 · Next test to confirm ALP origin from hepatobiliary
D system

MOCK-150 · Lec
M09

การยืนยันว่าค่า ALP ที่สูงขึ้นมาจากทางเดินน้ำดี/ตับ ไม่ใช่จากกระดูก ให้ส่งตรวจ Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) หรือ 5'-

Nucleotidase

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 150 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68

151. ตอบ A ข้อ 151 · Central pathogenic mechanism MOCK-151 · Lec M09

ภาวะ Hepatic encephalopathy เกิดจากการคั่งของสารพิษต่อระบบประสาท โดยเฉพาะแอมโมเนีย (Serum ammonia) เนื่องจากตับขจัดพิษได้ลดลงและมี Portosystemic shunting

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 151 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

152. ตอบ B ข้อ 152 · Diabetes category MOCK-152 · Lec M09

เบาหวานที่เกิดตามหลังโรคของตับอ่อนส่วน exocrine (เช่น Chronic pancreatitis) จัดอยู่ในกลุ่ม Pancreatogenic Diabetes Mellitus (Type 3c DM)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 152 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

153. ตอบ D ข้อ 153 · Diagnosis MOCK-153 · Lec M09

ภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์เฉียบพลัน (Acute alcoholic hepatitis) มีลักษณะเด่นคือค่า AST สูงกว่า ALT โดยมักมีอัตราส่วน AST:ALT > 2:1 และค่า AST มักไม่เกิน 300-500 U/L

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 153 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

154. ตอบ A ข้อ 154 · Diagnosis MOCK-154 · Lec M09

การอักเสบของลำไส้ใหญ่แบบต่อเนื่อง (Continuous lesion) เริ่มจากไส้ตรง (Rectum) ขึ้นไป และพบ Crypt abscesses โดยไม่มี granuloma คือโรค Ulcerative colitis (UC)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 154 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

155. ตอบ A ข้อ 155 · Diagnosis MOCK-155 · Lec M09

พยาธิสภาพอักเสบแบบข้ามส่วน (Skip lesions), เป็นทุกชั้นลำไส้ (Transmural), พบลักษณะ Cobblestoning และ Non-caseating granulomas คือโรค Crohn's disease

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 155 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68

156. ตอบ D ข้อ 156 · Immediate initial management MOCK-156 · Lec M09

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute pancreatitis) การรักษาเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันอวัยวะล้มเหลวคือ การให้สารน้ำ IV resuscitation

อย่างเต็มที่ (Isotonic crystalloids เช่น Lactated Ringer's)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 156 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

157. ตอบ C ข้อ 157 · Diagnosis MOCK-157 · Lec M09

ผลตรวจร่างกายพบ positive Murphy's sign ร่วมกับภาพอัลตราซาวด์พบผนังถุงน้ำดีหนาตัว และมีนิ่วอุดตันที่ cystic duct คือภาวะถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (Acute cholecystitis)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 157 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

158. ตอบ ข้อ 158 · Following initial resuscitation, definitive management MOCK-158 · Lec M09
E step

ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน (Upper GI bleeding) หลังกู้ชีพปรับสัญญาณชีพให้คงที่แล้ว ขั้นตอนการรักษาและห้ามเลือดที่แน่นอนคือการส่องกล้อง EGD ภายใน 24 ชั่วโมง

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 158 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

159. ตอบ E ข้อ 159 · First-line antibiotic treatment MOCK-159 · Lec M09

ลำไส้อักเสบจากเชื้อ Clostridioides difficile (CDI) ยาปฏิชีวนะรับประทานตัวเลือกแรกตามแนวทางปัจจุบันคือ Oral Vancomycin หรือ

Oral Fidaxomicin

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 159 · Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68

160. ตอบ D ข้อ 160 • Recommended initial management approach MOCK-160 • Lec M09

ผู้ป่วย GERD ที่ไม่มีสัญญาณเตือน (Alarm symptoms) การรักษาเริ่มต้นที่แนะนำคือ การปรับพฤติกรรม ร่วมกับการให้ยากดกรด oral PPI

วันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 160 • Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

161. ตอบ E ข้อ 161 • Appropriate eradication regimen MOCK-161 • Lec M09

การกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori สูตรแรกที่แนะนำ ได้แก่ Bismuth quadruple therapy หรือ Triple therapy (PPI + Amoxicillin + Clarithromycin) เป็นเวลา 10-14 วัน

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 161 • Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

162. ตอบ C ข้อ 162 • Diagnosis MOCK-162 • Lec M09

กลืนลำบากทั้งของแข็งและของเหลว ภาพถ่ายกะบังสีกบ Bird's-beak appearance และผลตรวจ manometry พบหูรูดล่างหลอดอาหารคลายตัวไม่สมบูรณ์ คือภาวะ Achalasia

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 162 • Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

163. ตอบ D ข้อ 163 • Definitive management MOCK-163 • Lec M09

โรคแพ้กลูเตน (Celiac disease) ยืนยันด้วย Anti-tTG IgA บวกพร้อมกับ villous atrophy การรักษาที่แน่นอนและต้องทำตลอดชีวิตคือการงดอาหารที่มีกลูเตน (Lifelong gluten-free diet)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 163 • Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68
-

164. ข้อ 164 • IV co-administration on days 1 and 3 proven to significantly MOCK-164 •
ตอบ B reduce renal impairment and m Lec M09

การให้ Intravenous Albumin ร่วมด้วยในวันที่ 1 และวันที่ 3 ของการรักษา SBP ช่วยป้องกันภาวะ Hepatorenal syndrome และลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 164 • Gastroenterology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.11** โรคระบบทางเดินอาหาร (ทั้งหมด) — 2.3.11 Disorders of the digestive system หน้า 68

165. ตอบ D ข้อ 165 • Renal failure type MOCK-165 • Lec M10

ปัสสาวะพบตะกอน Muddy brown granular casts ร่วมกับ FeNa > 2%
แสดงถึงการบาดเจ็บของเซลล์ท่อไตเฉียบพลันจากภาวะติดเชื้อกระแสเลือด (Acute Tubular Necrosis / Intrinsic AKI)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 165 • Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

166. ตอบ E ข้อ 166 • Clinical syndrome MOCK-166 • Lec M10

ครบเกณฑ์ Nephrotic syndrome: โปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะ > 3.5 g/day, อัลบูมินในเลือดต่ำ (< 3.0 g/dL), ไขมันในเลือดสูง และมีอาการบวมทั่วตัว

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 166 • Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

167. ตอบ ข้อ 167 • Early diabetic nephropathy hemodynamic mechanism MOCK-167 • Lec M10
B initiating disease

พยาธิสรีรวิทยาเริ่มต้นของโรคไตเบาหวาน (Diabetic nephropathy) เกิดจากภาวะ Glomerular hyperfiltration และความดันในกระจุกลอดเลือดไตสูง (Intraglomerular hypertension)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 167 • Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

168. ตอบ E ข้อ 168 • Diagnosis and first-line treatment MOCK-168 • Lec M10

โรค Nephrotic ในเด็กเล็กที่กล้างจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบ effacement of podocyte foot processes คือ Minimal Change Disease การรักษาอันดับแรกคือ Corticosteroids (Prednisolone)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 168 • Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

169. ตอบ A ข้อ 169 • Physiological change causing decline MOCK-169 • Lec M10

ยากลุ่ม ACEi ยับยั้ง Angiotensin II ทำให้หลอดเลือดนำเลือดออกจากกระจุไต (Efferent arteriole) คลายตัว ส่งผลให้แรงดันกรองในไต (Intraglomerular pressure) ดิ่งลงรุนแรงในผู้ป่วย Bilateral RAS

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 169 • Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70

170. ตอบ D ข้อ 170 · Appropriate initial fluid therapy MOCK-170 · Lec M10

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำรุนแรง (Severe hyponatremia) การแก้ไขโซเดียมต้องทำอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้อัตราการเพิ่มของโซเดียมเกิน 8-10

mEq/L ใน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกัน Osmotic Demyelination Syndrome (ODS)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 170 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

171. ข้อ 171 · Preventive measure indicated to minimize Contrast-Induced Nephropathy (CIN) MOCK-171 · Lec M10

มาตรการป้องกัน Contrast-Induced Nephropathy (CIN) ที่มีหลักฐานประสิทธิผลชัดเจนที่สุดคือ การให้สารน้ำ IV 0.9% Normal

Saline ก่อนและหลังการฉีดสารทึบรังสี

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 171 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

172. ตอบ E ข้อ 172 · Diagnosis MOCK-172 · Lec M10

ปัสสาวะสีโค้ก/ชา (Hematuria) ร่วมกับบวม ความดันสูง หลังติดเชื้อฉวยหนึ่ง Streptococcus มี C3 ต่ำ และไตพบ subepithelial humps คือ Post-Streptococcal Glomerulonephritis (PSGN)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 172 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

173. ตอบ C ข้อ 173 · Intervention administered FIRST to stabilize cardiac membrane MOCK-173 · Lec M10

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงรุนแรงที่มี EKG ผิดปกติสิ่งที่ต้องให้เป็นลำดับแรกสุดทันทีคือ IV Calcium Gluconate เพื่อปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ (Membrane stabilization) ป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตราย

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 173 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70

174. ตอบ A ข้อ 174 · Initial management strategy MOCK-174 · Lec M10

นิ่วในท่อไตขนาดเล็ก (< 5 mm) ที่ไม่มีภาวะอุดตันรุนแรงหรือติดเชื้อ การรักษาอันดับแรกคือแบบประคับประคอง (Conservative MET):

ยาแก้ปวด NSAIDs, สารน้ำ และ Alpha-blocker (Tamsulosin) เพื่อช่วยขับนิ่ว

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 174 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

175. ตอบ B ข้อ 175 · Diagnosis MOCK-175 · Lec M10

ถุงน้ำในไตสองข้าง ร่วมกับถุงน้ำในตับ และประวัติครอบครัวมีหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Berry aneurysm) แตก เป็นลักษณะคลาสสิกของ

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 175 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

176. ตอบ A ข้อ 176 · Diagnosis MOCK-176 · Lec M10

ปัสสาวะเป็นเลือดปนแดงสด 1-2 วันพร้อมๆ กับช่วงติดเชื้อทางเดินหายใจ (Synpharyngitic hematuria) ร่วมกับ C3 ปกติและพบ IgA

คั่งใน mesangium คือ IgA Nephropathy (Berger disease)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 176 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

177. ตอบ E ข้อ 177 · Diagnosis MOCK-177 · Lec M10

กลุ่มอาการปอดและไตอักเสบ (Pulmonary-renal syndrome) ร่วมกับตรวจพบ linear IgG deposition ตามแนว GBM และตรวจพบ Anti-GBM antibodies คือโรค Goodpasture Syndrome

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 177 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

178. ตอบ D ข้อ 178 · Diagnosis MOCK-178 · Lec M10

อาการ Triad (ไข้, ผื่น, Eosinophil ในปัสสาวะ) เกิดตามหลังการใช้ยา NSAIDs ร่วมกับมีไตอักเสบเฉียบพลัน คือภาวะ Acute Interstitial Nephritis (AIN)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 178 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70

179. ตอบ A ข้อ 179 · Secondary condition present MOCK-179 · Lec M10

ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ภาวะพอสเฟตในเลือดสูงและแคลเซียมต่ำจะกระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยด์หลั่ง PTH สูงขึ้นอย่างมาก เรียกว่า

Secondary Hyperparathyroidism (Renal Osteodystrophy)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 179 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

180. ตอบ A ข้อ 180 · Diagnosis MOCK-180 · Lec M10

ภาวะเลือดเป็นกรดจากไตที่ไม่สามารถขับ H⁺ ที่ distal tubule ทำให้ pH ปัสสาวะสูงกว่า 5.5 เสมอ ร่วมกับมีโพแทสเซียมต่ำ คือ Type 1

(Distal) Renal Tubular Acidosis

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 180 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

181. ตอบ B ข้อ 181 · Renal structure primarily damaged MOCK-181 · Lec M10

พิษต่อไตจากยาปฏิชีวนะกลุ่ม Aminoglycosides (เช่น Gentamicin) มีเป้าหมายทำลายเซลล์เยื่อหุ้มไตส่วนต้น (Proximal tubular

epithelial cells) ทำให้เกิด non-oliguric ATN

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 181 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70
-

182. ตอบ B ข้อ 182 · Immediate step MOCK-182 · Lec M10

ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (Postrenal AKI / Acute urinary retention)

สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการใส่สายยางสวนปัสสาวะ (Foley catheterization) เพื่อระบายปัสสาวะอุดกั้น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 182 · Nephrology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.14** โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (ทั้งหมด) — 2.3.14 Disorders of the genito-urinary system หน้า 70

183. ตอบ A ข้อ 183 · Assay confirming definitive etiology of Graves' disease MOCK-183 · Lec M11

การยืนยันวินิจฉัยโรค Graves' disease ที่เป็นสาเหตุภูมิคุ้มกันต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ตรวจยืนยันด้วย Thyroid-Stimulating Receptor Antibodies (TRAb / TSI)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 183 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

184. ตอบ C ข้อ 184 · Preferred antithyroid med during 1st trimester to minimize teratogenic risks MOCK-184 · Lec M11

การรักษาไทรอยด์เป็นพิษในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก ยาด้านไทรอยด์ที่แนะนำคือ Propylthiouracil (PTU) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงพิการแต่กำเนิดจาก Methimazole (เช่น aplasia cutis)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 184 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

185. ตอบ C ข้อ 185 · Comprehensive immediate management for Thyroid Storm MOCK-185 · Lec M11

การรักษาภาวะ Thyroid Storm ต้องครอบคลุม 4 ด้านหลัก: PTU/MMI (ยับยั้งการสร้าง), Propranolol (คุมอาการและยับยั้ง T4->T3), Lugol's iodine (ยับยั้งการหลั่ง) และ Hydrocortisone (ป้องกัน adrenal crisis และลด T4->T3)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 185 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

186. ตอบ A ข้อ 186 · Diagnosis MOCK-186 · Lec M11

ภาวะ Free T4 ต่ำ โดยที่ TSH ไม่สูงขึ้นตามปกติ (อยู่ในช่วงปกติหรือต่ำ) เป็นลักษณะของ Secondary / Central Hypothyroidism (ความผิดปกติที่ต่อมใต้สมองหรือไฮโปทาลามัส)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 186 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64

187. **ตอบ D** ข้อ 187 • **Diagnosis** MOCK-187 • Lec M11

ผู้ป่วยวิกฤตใน ICU ที่ตรวจพบระดับ Free T3 ต่ำโดดเดี่ยว โดย TSH และ T4 ปกติคือภาวะ Euthyroid Sick Syndrome (Non-thyroidal illness syndrome) ไม่ต้องรักษาด้วยไทรอยด์ฮอร์โมน

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 187 • Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

188. **ตอบ D** ข้อ 188 • **Most sensitive standardized bedside clinical test** MOCK-188 • Lec M11

การตรวจคัดกรองภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic neuropathy) ที่แม่นยำและเป็นมาตรฐานที่สุดคือ การทดสอบด้วย

10-gram Semmes-Weinstein Monofilament

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 188 • Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

189. **ตอบ B** ข้อ 189 • **Initial management step** MOCK-189 • Lec M11

ขั้นตอนการรักษาอันดับแรกสุดในภาวะ Diabetic Ketoacidosis (DKA) คือการเปิดสารน้ำ IV 0.9% Normal Saline เพื่อกู้คืนปริมาตรเลือดและแก้ไขภาวะขาดน้ำก่อนเริ่มอินซูลิน

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 189 • Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

190. **ตอบ D** ข้อ 190 • **Primary diagnosis** MOCK-190 • Lec M11

น้ำตาลในเลือดสูงมาก (> 600 mg/dL), ความเข้มข้นเลือดสูงมาก (> 320 mOsm/kg) โดยไม่มีภาวะเป็นกรดหรือคีโตนในปัสสาวะ

เป็นลักษณะเฉพาะของ Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 190 • Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

191. **ตอบ B** ข้อ 191 • **Oral agent class providing proven renoprotection and slowing CKD progression** MOCK-191 • Lec M11

ยาลดน้ำตาลกลุ่ม SGLT2 inhibitors (เช่น Empagliflozin, Dapagliflozin) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามียุทธวิธี ปกป้องไต (Renoprotection) และชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 191 • Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64

192. ตอบ ข้อ 192 · Entity encompassing combination of organ-specific autoimmune disorders

MOCK-192 · Lec M11

การพบโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองของต่อมไร้ท่อหลายอวัยวะร่วมกัน (เช่น T1DM + Hashimoto's + Vitiligo) จัดอยู่ในกลุ่ม Polyglandular Autoimmune Syndrome (PAS)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 192 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

193. ตอบ B ข้อ 193 · Best initial screening test for Cushing's syndrome

MOCK-193 · Lec M11

การตรวจคัดกรองภาวะ Cushing's syndrome อันดับแรกทำได้โดยส่งตรวจ 24-hour Urinary Free Cortisol หรือ Overnight 1-mg Dexamethasone Suppression Test

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 193 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

194. ตอบ D ข้อ 194 · Diagnostic test confirming Addison's disease

MOCK-194 · Lec M11

การยืนยันภาวะต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องระยะแรก (Primary adrenal insufficiency / Addison's disease) คือการทำ Cosyntropin (ACTH) Stimulation Test แล้ววัดระดับคอร์ติซอล

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 194 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

195. ตอบ E ข้อ 195 · Test confirming diagnosis of Acromegaly

MOCK-195 · Lec M11

การยืนยันวินิจฉัยโรค Acromegaly ทำโดยการตรวจวัดระดับ Growth Hormone (GH) หลังรับประทานน้ำตาลกลูโคส (OGTT) ซึ่งในคนปกติ GH ต้องถูกกดจนต่ำกว่า 1 ng/mL

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 195 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

196. ตอบ D ข้อ 196 · Diagnosis

MOCK-196 · Lec M11

ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงร่วมกับฮอร์โมนพาราไธรอยด์ (PTH) สูงผิดปกติพบบ่อยที่สุดจากเนื้องอกเนื้องามเนื้องอกก้อนเดียว (Parathyroid adenoma) วินิจฉัยเป็น Primary Hyperparathyroidism

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 196 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- **NL 2.3.4** โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64

197. ตอบ A ข้อ 197 · First-line pharmacologic class MOCK-197 · Lec M11

เนื้องอกต่อมใต้สมองชนิด Prolactinoma การรักษาตัวเลือกแรกคือการใช้ยาต้านปรอทกลุ่ม Dopamine Agonists (เช่น Cabergoline

หรือ Bromocriptine) ซึ่งช่วยลดขนาดก้อนและระดับฮอร์โมนได้ดีมาก

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 197 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.4 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

198. ตอบ C ข้อ 198 · Immediate management MOCK-198 · Lec M11

ภาวะแคลเซียมต่ำเฉียบพลันหลังผ่าตัดไทรอยด์ (Hypocalcemia post-thyroidectomy) ที่มีอาการเกร็ง Chvostek's sign ให้ผลบวก

ต้องให้การรักษาฉุกเฉินด้วย IV Calcium Gluconate ทันที

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 198 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.4 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

199. ตอบ B ข้อ 199 · Drug class initiated BEFORE surgery MOCK-199 · Lec M11

เนื้องอก Pheochromocytoma ก่อนผ่าตัดต้องให้ยา Alpha-blocker (เช่น Phenoxybenzamine) นำก่อนเสมออย่างน้อย 10-14 วัน ก่อนจะให้ Beta-blocker ตามทีหลัง เพื่อป้องกันวิกฤตความดันดันโลหิตสูง (Unopposed alpha-stimulation)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 199 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.4 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

200. ตอบ E ข้อ 200 · Primary diagnosis MOCK-200 · Lec M11

ความดันโลหิตสูงดื้อยา ร่วมกับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ และผลตรวจ Aldosterone-to-Renin Ratio (ARR) > 30 โดยที่ Renin ถูกกดต่ำ

เป็นการวินิจฉัย Primary Aldosteronism (Conn syndrome)

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- NL Part 1 Mock Assessment (200 ข้อ) — ข้อ 200 · Endocrinology

เกณฑ์แพทยสภา พ.ศ. 2567 (NL)

- NL 2.3.4 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิก (ทั้งหมด) — 2.3.4 Endocrine, nutritional and metabolic disorders หน้า 64
-

Part 2 · MEQ — แนวคำตอบ

Part 3 · OSCE / SAQ — แนวคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน

ส่วนที่ 3 • คลังข้อสอบเก่า MED28 - MED35

0 ข้อ จัดกลุ่มตาม lecture พร้อมระบุรุ่น ครั้งที่สอบ loop และเลขข้อ
